



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI**

**BULAN JUNI
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum/Latar belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Disisi lain, rumah sakit menjadi mata rantai transmisi penyakit. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai nega di dunia, termasuk Indonesia. Dalam forum *Asian Pasific Economic Comitte* (APEC) atau *Global Health Security Agenda* (GHSA) penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara.

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, perawatan pasien tidak hanya dilayani di rumah sakit saja tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bahkan di rumah (*home care*).

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 449.5/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1.3. Maksud dan Tujuan

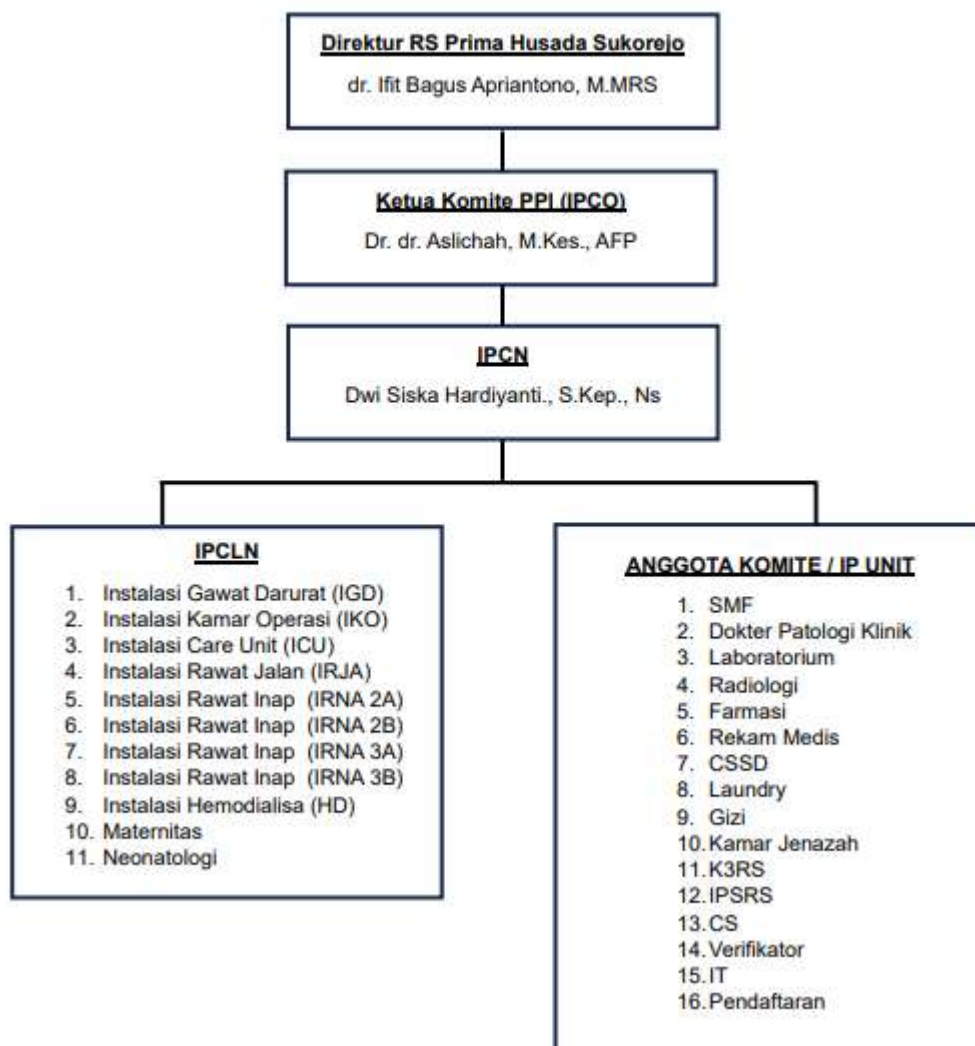
Sebagai panduan untuk pencapaian visi dan misi RS Prima Husada Sukorejo dalam mencapai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan professional melalui penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, sehingga setiap individu dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur.

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
Menjadikan rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan Masyarakat
- 2.2 Misi
1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat.
 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
- 2.3 Motto
“Clean Hands, Save Lives”
- 2.4 7 Nilai Budi Utama
1. Jujur
 2. Tanggung jawab
 3. Dipercaya
 4. Visioner
 5. Kerjasama
 6. Adil
 7. Peduli
- 2.5 SOTK

Gambar 1. SOTK Komite PPI 2025

SOTK KOMITE PPI



BAB III.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
- 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Jumlah SDM												Kebutuhan	Ket.
		Bulan Ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IPCO	1	1	1	1	1	1	1							1	Peremenkes No 27 tahun 2017 1 IPCN = 100 TT
IPCD	1	-	-	-	-	-	-							1	
IPCN	1	1	1	1	1	1	1							1-2	

- 3.1.2 Orientasi
- Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi PPI RSPH Pasuruan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi orientasi
1.	Januari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Januari 2025		
2.	Februari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Februari 2025		
3.	Maret	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Maret 2025		
4.	April	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan April 2025		
5.	Mei	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Mei 2025		
6.	Juni	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Juni 2025		
Total				

3.1.3 Evaluasi Kinerja Staf

Tabel 3.1.4.1 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Surveilans

UNIT	SURVEILANS												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	100	100	100	100	85							98
IGD	80	100	100	85	85	85							89
IKO	60	50	0	50	50	0							35
IRJA	40	80	100	100	100	85							84
IRNA 2A	100	100	100	100	100	85							98
IRNA 2B	80	100	80	100	100	85							91
IRNA 3A	100	100	80	100	100	85							94
IRNA 3B	80	100	80	100	100	85							91
MATER	100	100	80	100	100	85							94
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100	85							98
GIZI & DAPUR	0	0	0	0	0	0							0
FARMASI	0	0	0	0	0	0							0
LAB	0	0	0	0	0	0							0
RM & PDF	0	0	0	0	0	0							0
RADIOLOGI	0	0	0	0	0	0							0
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0							0



Tabel 3.1.4.2 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Bulanan

UNIT	LAPORAN BULANAN												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	80	80	80	80	80	80							80
IGD	80	80	80	80	60	80							77
IKO	60	50	80	50	50	0							48
IRJA	40	80	80	80	80	80							73
IRNA 2A	80	80	80	80	80	80							80
IRNA 2B	80	80	80	80	80	80							80
IRNA 3A	80	80	80	80	80	80							80
IRNA 3B	80	65	80	80	80	80							78
MATER	80	80	80	80	80	80							80
NEONATOLOGI	80	80	80	80	80	80							80
GIZI & DAPUR	80	80	80	80	80	80							80
FARMASI	60	80	60	60	60	80							73
LAB	80	80	80	80	80	0							63
RM & PDF	60	70	60	60	60	50							60
RADIOLOGI	60	70	60	60	60	50							60
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0							0



Tabel 3.1.4.3 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Edukasi

UNIT	LAPORAN EDUKASI												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	100	100	100	100	100							100
IGD	100	100	100	0	100	100							83
IKO	0	0	0	0	0	0							0
IRJA	0	50	100	0	100	0							42
IRNA 2A	50	50	100	100	100	100							83
IRNA 2B	50	100	100	100	100	100							92
IRNA 3A	100	100	100	100	100	100							100
IRNA 3B	50	100	100	100	100	100							92
MATER	100	100	100	100	100	100							100
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100	100							100
GIZI & DAPUR	0	0	0	0	0	0							0
FARMASI	0	0	0	0	0	0							0
LAB	0	0	0	0	0	0							0
RM & PDF	50	50	0	100	100	100							67
RADIOLOGI	0	0	50	50	0	0							17
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0							0

Tabel 3.1.4.5 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit HH

UNIT	LAPORAN HH												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	100	80	80	70	80							85
IGD	100	100	100	60	100	70							88
IKO	80	70	0	0	50	0							33
IRJA	60	80	60	100	100	70							78
IRNA 2A	100	100	100	100	100	100							100
IRNA 2B	100	100	80	80	100	100							93
IRNA 3A	100	100	80	80	80	100							90
IRNA 3B	100	40	80	80	100	100							83
MATER	100	100	80	100	100	100							97
NEONATOLOGI	100	100	80	100	100	100							97
GIZI & DAPUR	100	100	80	100	100	100							97
FARMASI	60	100	0	100	100	100							77
LAB	80	100	80	100	0	0							60
RM & PDF	0	0	0	0	0	0							0
RADIOLOGI	60	80	0	0	50	50							40
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0							0

Tabel 3.1.4.6 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit APD

UNIT	LAPORAN AUDIT APD												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	80	100	100	0	100							80
IGD	80	80	100	100	100	100							93
IKO	60	60	0	0	50	0							28
IRJA	0	0	80	100	100	100							63
IRNA 2A	80	80	80	100	100	100							90
IRNA 2B	80	80	80	100	100	100							90
IRNA 3A	100	80	80	100	100	100							93
IRNA 3B	80	60	80	100	100	100							87
MATER	100	100	80	100	100	100							97
NEONATOLOGI	100	100	80	100	100	100							97
GIZI & DAPUR	80	80	80	100	100	100							90
FARMASI	60	100	0	100	100	0							60
LAB	80	100	80	100	100	100							77
RM & PDF	0	0	0	0	0	0							0
RADIOLOGI	60	80	0	0	0	0							23
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0							0

[illegible]

Tabel 3.1.4.8 Hasil Penilaian PIC PPI Unit Bulan Juni 2025

UNIT	SURVEILANS	LAPBUL	EDUKASI	AUDIT HH	AUDIT APD	AUDIT PROGRAM	NILAI
ICU	98	80	100	85	80	0	74
IGD	89	77	83	88	93	0	72
IKO	35	48	0	33	28	0	24
IRJA	84	73	42	78	63	0	57
IRNA 2A	98	80	83	100	90	0	75
IRNA 2B	91	80	92	93	90	0	74
IRNA 3A	94	80	100	90	93	0	76
IRNA 3B	91	78	92	83	87	0	72
MATER	94	80	100	97	97	0	78
NEONATOLOGI	98	80	100	97	97	0	78
GIZI & DAPUR	0	80	0	97	90	0	44
FARMASI	0	73	0	77	60	0	35
LAB	0	63	0	60	77	0	33
RM & PDF	0	60	67	0	0	0	21
RADIOLOGI	0	60	17	40	23	0	23
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3.1.4.9 Analisa dan Tindak Lanjut Penilaian Kinerja PIC PPI Unit 2025

Analisa	Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi penilaian kinerja staf IPCLN dan PIC PPI bulan Juni tahun 2025 dengan penugasan sebagai berikut, - Pelaporan surveilans - Pelaporan dan penginputan laporan <i>by link</i> - Pemberian edukasi kelompok dan individu dengan sasaran pasien, pengunjung serta staf unit - Pelaporan audit HH - Pelaporan audit APD - Pelaporan audit program Dapat diketahui bahwa pelaporan belum berjalan secara maksimal, dan masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan secara <i>real time</i>. Adapaun unit dengan rerata skoring tertinggi dan menjadi PIC teladan pada bulan Juni tahun 2025 yakni Neonatologi dan Maternitas dengan skor 78
Rencana Tindak Lanjut	- Berikan penilaian kinerja setiap bulan pada saat melakukan rapat koordinasi komite PPI - Lakukan koordinasi dengan SDM dan berikan reward kepada unit teladan setiap bulannya - Lakukan koordinasi dengan Kabid terkait hasil temuan-temuan setiap bulannya - Lakukan perbaikan dengan IPCN setiap kali melakukan agenda rapat dalam pembahasan temuan-temuan serta kendala pada masing-masing unit - Berikan motivasi kepada semua PIC PPI unit yang baik yang sudah dan belum maksimal dalam melakukan penugasan serta evaluasi secara bersama dengan IPCN - Lakukan koordinasi dengan Kabid serta SDM terkait kepatuhan unit dan staff dalam proses menjadi seorang PIC PPI di unit serta dalam melakukan monitoring PPI di masing-masing unit

3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan

Tabel 3.2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan	Bulan	Hasil	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelatihan	Januari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Januari 2025		
2	Pelatihan	Februari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Februari 2025		
3	Pelatihan	Maret (22/03/2025)	1. IDO (Infeksi daerah operasi) bisa di sebabkan oleh faktor endogen (usia, penyakit penyerta, jenis kelamin, pola hidup) dan eksogen (tipe dan lama operasi, keahlian tim bedah, pemilahan operasi, pemasangan impaln, sterilisasi instrumen bedah, kualitas ruang op, kualitas fasilitas/peralatan yang ada di ruang operasi) 2. 4 klasifikasi luka IDO 1) Luka bersih 1-2% 2) Bersih terkontaminasi 6-9% 3) Luka terkontaminasi 13-20% 4) Luka kotor 40% 3. Pemberian profilaksis di lakukan 1 jam sebelum insisi dan sesegera mungkin sebelum dilakukan pembedahan 4. Pemberian profilaksis harus berbeda dengan terapi AB yang digunakan pasien selama proses rawat inap 5. Dikatakan IDO ketika 1) post op hari ke 30-90 yang disertai dengan demam, kemerahan, bengkak, keluar pus	1. Belum adanya SPO pembersihan ruang IKO yang ter-update 2. Tidak patuh dan rutinnya jadwal bongkaran di ruang IKO 3. Tidak patuhnya staff IKO dalam melakukan tatalaksana ruang operasi sesuai dengan prosedur 4. Penerapan bundle IDO di RS belum berjalan sesuai dengan standart 5. Jadwal pemberian profilaksis (antibiotik) di setiap unit masih belum berjalan maksimal 60 menit sebelum jam insisi 6. Masih ditemukan alat di ruang IKO tidak terpusat di CSSD dalam proses pembersihan	1. Pembuatan SPO pembersihan ruang IKO 2. Pembuatan jadwal bongkaran IKO 3. Sosialisasi dan re-edukasi kepatuhan petugas dalam melaksanakan tatalaksana ruang operasi 4. Penerapan bundle IDO oleh unit IKO dan all unit rawat inap serta rawat jalan 5. Edukasi pemberian profilaksis (antibiotik) harus 60 menit sebelum insisi 6. CSSD melakukan pendaataan dan edukasi ulang terkait instrumen yang ada di IKO wajib dilakukan pembersihan dan sterilisasi di CSSD



			2) golden period terjadi pada hari ke 0-30 hari 6. Dampak IDO 1) memperpanjang masa rawat, sering re-admisi, kebutuhan ICU 2) mortalitas meningkat 3) disabilitas permanen 4) prosedur bedah tambahan 5) kontribusi pada peningkatan resistensi antibiotik 7. Teknik penerapan IDO 1) Pre operatif : mandi dengan clorhexidin sehari sebelum op dan hari H ketika proses pembedahan, pencukuran menggunakan cleaper (dilakukan di RS supaya terkontrol oleh petugas tekniknya), pemberian antibiotik kurang dari 120 menit 2) Intra operatif : pemberian O2, pemantauan suhu tubuh, pemantauan gula darah 8. Bongkaran/pembersihan IKO 1) pembersihan harian (dilakukan selama prosedur op telah selesai semua) 2) bongkaran 1 minggu sekali (dilakukan secara rutin dan terjadwal) 3) bongkaran 1 bulan sekali 4) pembersihan pasca renovasi 9. Pembersihan lingkungan		
--	--	--	--	--	--



			1) terdapat SPO tersendiri dalam pembersihan ruang khusus (iko) 2) melakukan pemeriksaan lingkungan secara rutin (6 bulan sekali) 10. kualitas ruang operasi 1) pintu otomatis 2) tempat cuci tangan menggunakan sensor 11. alur instalasi ruang bedah 1) zona luar : koridor masuk, area transfer, nurse station, area dokumentasi, preoperasi, area ganti baju 2) zona bersih : koridor bersih, ruang simpan alat steril, ruang anastesi dan RR, area istirahat 3) zona retriksi : scrub sinks, ruang operasi 12. persiapan alat/instrumen 1) alat "non kritis" 2) alat "semi kritis" 3) alat "kritis" 13. prinsip rawat luka pasien post op 1) assesmen komprehensif luka dan pasien 2) pengendalian infeksi 3) pemilihan dressing yang tepat 4) manajemen nyeri 5) pendidikan pasien dan keluarga 14. tata kelola kamar operasi		
--	--	--	--	--	--



			1) penjadwalan operasi : mengatur (mengatur kamar operasi, operator dna tim operasi, durasi op) 2) persiapan pasien 3) koordinasi tim medis 4) pengurangan waktu tunggu 5) alur pasien yang efisien 15. manajemen linen 1) penanganan linen di kamar op harus sesuai 2) pemisahan linen kotor terkontaminasi darah atau cairan tubuh dengan linen kotor tidak terkontaminasi 3) tidak menempatkan linen di lantai 4) semua linen infeksius dimasukkan ke dalamkantong dengan kode infeksius 5) linen yang terkontaminas cairan tubuh dibersihkan sebelum proses selanjutnya 16. manajemen limbah 1) pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya 2) tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya 17. sterilisasi dan perawatan peralatan medis 1) sterilisasi alat bedah 2) desinfeksi permukaan 3) penyimpanan yang tepat 4) pemeliharaan yang rutin		
--	--	--	---	--	--

			18. semua peralatan/instrumen bedah wajib di lakukan sterilisasi di CSSD 19. ruang/gedung kamar operasi : boleh sampai dengan lt. 4 dengan memperhatikan struktur dan arah cahaya dari banguna		
4	Pelatihan	April 2025	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan April 2025		
5	Pelatihan	Mei 2025	Total Undangan: 466 peserta Total Kehadiran: 322 peserta Total Tidak Hadir: 144 peserta Persentase Kehadiran: 69,10% Persentase Ketidakhadiran: 30,90% Nilai Rata-Rata Peserta: Pre-Test : 88 / 100 Post-Test : 95 / 100 Rata-rata tanya jawab saat praktik : 74,06 / 80 Hasil Pelatihan PPI All Staff 1. Cuci Tangan a. Staff tidak melakukan pelepasan aksesoris, namun Ketika sudah dilakukan edukasi dan sosialisasi staff paham b. Langkah cuci tangan terbolak balik antara Langkah ke 3 dan ke 4 c. Langkah cuci tangan “mengunci” menjadi kendala dari staff pelatihan	1. Kehadiran Peserta: Persentase kehadiran sebesar 69,10% menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, namun masih ada sekitar 30,90% peserta yang tidak hadir. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut terkait alasan ketidakhadiran (jadwal, sosialisasi, dukungan pimpinan, dsb). 2. Peningkatan Nilai - Terdapat peningkatan nilai dari 88 (pre-test) menjadi 95 (post-test), yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap materi PPI meningkat setelah pelatihan. - Rata-rata post-test mendekati sempurna, mengindikasikan bahwa materi disampaikan dengan	1. Evaluasi Ketidakhadiran: - Lakukan survei singkat atau konfirmasi ke unit terkait untuk mengetahui penyebab utama ketidakhadiran 146 peserta. - Koordinasikan dengan pimpinan unit untuk mendukung keikutsertaan dalam pelatihan selanjutnya. 2. Pelatihan Ulang: - Jadwalkan sesi pelatihan susulan atau pelatihan ulang bagi peserta yang tidak hadir untuk memastikan seluruh SDM memahami PPI dasar. 3. Monitoring dan Implementasi - Lakukan audit kepatuhan terhadap PPI pasca pelatihan untuk menilai



			d. Langkah cuci tangan ke dua “punggung tangan” banyak staff yang tidak menempelkan telapak tangan ke punggung tangan e. Masih ada beberapa staff yang tidak hafal 5 momen cuci tangan f. Masih ada beberapa staff yang tidak hafal terkait waktu cuci tangan g. Masih belum pahamnya staff terkait tujuan dan manfaat cuci tangan 2. Spillkit a. Staff belum paham penggunaan spillkit b. Staff tidak paham isi dan kegunaan spillkit c. Staf masih bingung terkait Langkah-langkah penggunaan spill kit dan masih terbolak balik Langkah, a) Penggunaan APD (urutan penggunaan dan pelepasan APD) b) Penyiapan kresek c) Pemberian pasir/serbuk kayu dengan jarak 10-20 cm d) Kapan pemberian klorin pada saat ada tumpahan DUH pasien e) Penggunaan klorin tidak dipakai pada saat terjadi tumpahan B3	efektif dan dapat diterima dengan baik oleh peserta. - Rata-rata tanya jawab langsung ketika melakukan praktikum sebesar 74,06 yang menunjukkan peserta 3. Kurang patuhnya staff unit dalam menerapkan 6 langkah cuci tangan dan	penerapan di unit kerja masing-masing - Berikan feedback berkala ke unit terkait praktik PPI (misalnya: kebersihan tangan, penggunaan APD, etika batuk, dll) 4. Peningkatan Berkelanjutan: - Sertakan materi PPI dasar dalam orientasi karyawan baru. - Rancang materi PPI lanjutan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman dan kompetensi staf Rencana Tindak Lanjut terkait Materi praktek dalam PPI, 1. Cuci Tangan a. Melakukan pelatihan ulang berbasis demonstrasi langsung dan praktik. b. Menyediakan poster visual 6 langkah cuci tangan dan 5 momen WHO di setiap unit. c. Evaluasi dan simulasi periodik.
--	--	--	--	--	---



			3. Penggunaan APD a. Staff belum paham dan masih terbolak balik dalam urutan penggunaan APD b. Staff belum paham dan masih terbolak balik dalam urutan pelepasan APD c. Kebutuhan APD di unit sudah terpenuhi, hanya unit IRNA 2A (R. Isolasi yang belum memenuhi kebutuhan APD masker N95 yang diperuntukkan untuk masuk keruang isolasi) 4. Pemilahan sampah a. Staff bingung dalam melakukan pembuangan cairan DUH pasien dan pembuangan botol yang terkena DUH pasien infus kemana b. Staff bingung dalam melakukan pengikatan sampah infeksius/non infeksius/ botol infus 5. Penanganan Linen a. Staff masih bingung Ketika ditemukan DUH pasien di linen (harus di buang dulu DUH pasien) lalu di masukkan kedalam kresek infeksius 6. Proses Dekontaminasi alat a. Staff masih bingung untuk proses awal perendaman / dekontaminasi dari unit (alat		d. Kampanye mini tentang manfaat cuci tangan melalui media internal (TV, flyer, poster). e. Penugasan role model (champion hygiene) di tiap unit. 2. Spillkit a. Melakukan pelatihan ulang menggunakan alat spillkit secara langsung. b. Membuat SOP visual/spillkit flowchart yang ditempatkan di area risiko tinggi. c. Simulasi rutin tumpahan DUH dan B3. d. Pemberian kartu ringkasan urutan spillkit untuk staf. 3. Penggunaan APD a. Pelatihan ulang dengan simulasi step-by-step penggunaan dan pelepasan APD. b. Penambahan kebutuhan APD ke IRNA 2A. c. Menempelkan panduan poster urutan APD di setiap ruang tindakan.
--	--	--	--	--	---



			direndam terlebih dahulu menggunakan cairan deterjen kemudian di turunkan ke CSSD) b. Beberapa alat setelah di pakai tidak di turunkan dikarenakan lupa, dan hanya diletakkan di dalam kresek kuning, bukan di box instrument kotor		d. Pembuatan video internal panduan penggunaan APD. 4. Pemilahan Sampah a. Penyusunan ulang SOP pemilahan limbah dengan contoh visual. b. Sosialisasi dan simulasi secara langsung. c. Penempatan label warna yang jelas pada setiap kantong dan tempat sampah. 5. Penanganan Linen a. Sosialisasi prosedur penanganan linen terkontaminasi DUH secara rinci. b. Pelatihan simulasi dan role play. c. Penempatan instruksi singkat di area laundry dan tempat pengumpulan linen. 6. Dekontaminasi Alat a. Edukasi ulang urutan dekontaminasi alat: dari perendaman hingga
--	--	--	---	--	--



					pengiriman yang dilakukan oleh statff CSSF
					b. Audit harian terhadap kepatuhan pengiriman alat kotor ke CSSD.

3.3 Kinerja Produktifitas Komite PPI

3.3.1 Kewaspadaan Isolasi

a. Kewaspadaan Standart

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PENYUNTIKAN YANG AMAN	80,00%	89,30%	86,50%	82,22%	81,64%	95,37%	89,54%							87,43%	86,01%	88,85%
2	PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI VAKSIN	80,00%	100,00%	94,44%	95,39%	92,88%	100,00%	100,00%							97,12%	96,61%	97,63%
3	PENGELOLAAN STERILISASI DAN BMHP	80,00%	97,24%	92,72%	90,27%	93,33%	95,80%	96,28%							94,27%	93,41%	95,14%
4	PENGELOLAAN LINEN/LAUNDRY	80,00%	96,43%	88,31%	89,01%	87,07%	90,48%	94,44%							90,96%	91,25%	90,66%
5	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS RS	80,00%	100,00%	94,05%	94,41%	96,88%	96,58%	98,77%							96,78%	96,15%	97,41%
6	PENANGANAN SPESIMEN DARAH DAN CAIRAN TUBUH LAIN	80,00%	90,48%	100%	92,50%	96,88%	98,75%	98,75%							96,23%	94,33%	98,13%
7	PENANGANAN TUMPAHAN DARAH DAN CAIRAN TUBUH	80,00%	91,09%	85,96%	84,43%	94,05%	89,90%	95,22%							90,11%	87,16%	93,06%
8	PENANGANAN DAN PENGIRIMAN SAMPAH DI RUANGAN	80,00%	93,33%	95,36%	84,63%	90%	93,75%	91,41%							91,41%	91,11%	91,72%
9	PEMBUANGAN BENDA TAJAM	80,00%	72,77%	72,08%	87,73%	92,71%	94,64%	92,36%							85,38%	77,53%	93,24%
10	PELAYANAN MAKANAN	80,00%	75,00%	90,83%	85,00%	91,64%	94,17%	94,05%							88,45%	83,61%	93,29%
11	LINGKUNGAN RUMAH SAKIT	80,00%	33,70%	63,31%	70,94%	95,17%	85,71%	86,24%							72,35%	56,65%	88,05%
12	KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN APD DI UNIT	80,00%	96,45%	91,42%	94,21%	95,17%	99,38%	92,70%							94,89%	94,03%	95,75%
13	KAMAR JENAZAH	80,00%	87,50%	91,43%	95,24%	100%	100,00%	100,00%							95,70%	91,39%	100,00%

14	FASILITAS KEBERSIHAN TANGAN	80,00%	96,59%	95,83%	93,43%	91,89%	94,97%	93,33%							94,34%	95,28%	93,40%
15	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULAN	80,00%	95,00%	90%	87,78%	96,67%	91,16%	83,33%							90,66%	90,93%	90,39%
16	ETIKA BATUK	80,00%	98,61%	99,16%	78,85%	90,28%	86,67%	89,29%							90,48%	92,21%	88,75%
17	KELENGKAPAN PENGISIAN DATA PPI	80,00%	47,08%	58,53%	75,43%	67,58%	74,49%	73,37%							66,08%	60,35%	71,81%

b. Kewaspadaan Isolasi

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA- RATA	RATA- RATA TW I	RATA- RATA TW II
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PENEMPATAN PASIEN INFEKSI AIRBONE DALAM WAKTU SINGKAT	80,00%	-	-	-	-	-	-							-	-	-
2	PENEMPATAN PASIEN IMMUNOCOMPROMISED	80,00%	62,50%	58,33%	95,00%	85%	58,33%	83,33%							73,75%	71,94%	75,55%
3	PENEMPATAN DAN TRANSFER INFEKSI PASIEN AIRBONE	80,00%	63,49%	73,15%	78,42%	68,25%	68,52%	87,50%							73,22%	71,69%	74,76%

3.3.2 Audit Bundle HAI's PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CAUTI		0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	0,00%	0,00%		
2	CLABSI		0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	0,00%	0,00%		
3	VAP		0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	0,00%	0,00%		
4	PLEBITIS & PLABSI		1,39%	1,14%	2,41%	2,08%	3,49%	3,46%							2,33%	1,65%	3,01%		
5	IDO		0%	0,89%	1,19%	0%	0%	0%							0,35%	0,69%	0,00%		
6	DEKUBITUS		0%	0%	2	0	0	0							0,33	0,66	0		

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KET	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CAUTI (ISK)	HARI PEMAKAIAN	62	142	174	195	52	82							118	126	110		
2	CLABSI (CVC)		11	10	13	4	4	7							8	11	5		
3	VAP		41	13	34	14	30	28							27	29	24		
4	IDO	JUMLAH PASIEN OP DALAM PERIODE TERTENTU (BULAN)																	
	SC		81	63	92	92	82	77							81	79	84		
	ORIF		25	40	42	42	31	33							36	36	35		
	APENDICTOMI		12	9	3	8	10	15							10	8	11		
	HERNIOTOMI		25	22	11	16	28	22							21	19	22		
	KATARAK		31	33	29	30	30	30							31	31	30		
	CABG		0	0	0	0	0	0							0	0	0		
	TU MAMAE		20	20	15	22	25	30							22	18	26		
	LAPAROTOMI		26	37	22	13	19	30							25	28	21		

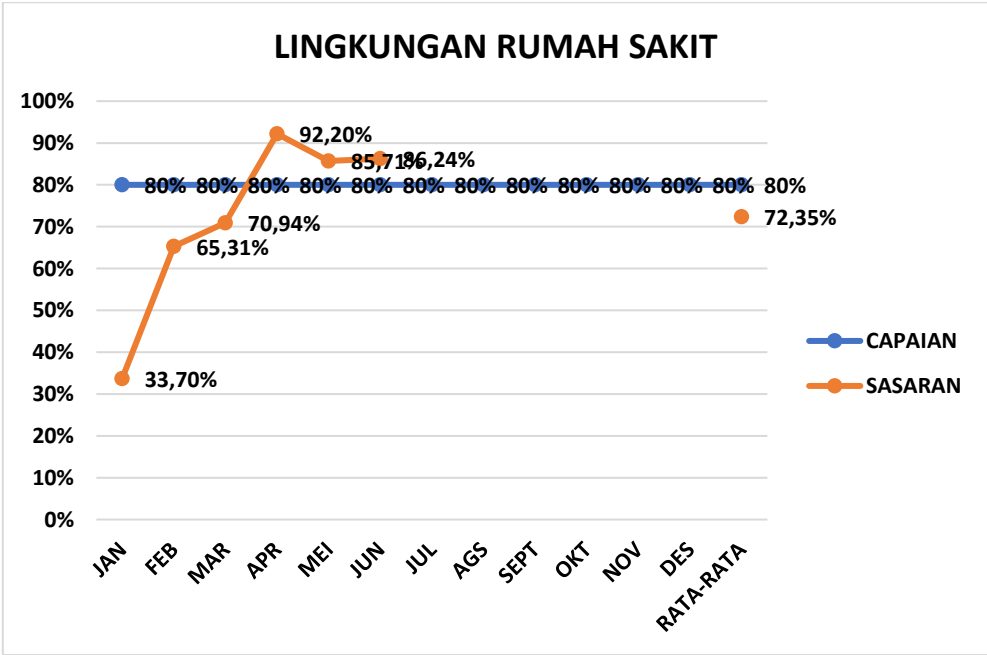
3.3.3 Mutu PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	62%	82,75%	81,80%	82,39%	96,86%	90,00%							80,95%	75,38%	86,52%
2	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI's (Health care Associated Infection) di RS	75%	3,55%	1,07%	3,87%	6,33%	75,85%	69,66%							26,72%	2,83%	50,61%
3	Kepatuhan kebersihan tangan	>85%	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%							80,83%	76,98%	84,68%
4	Kepatuhan APD	100%	89,64%	89,87%	84,84%	97,92%	98,07%	93,80%							92,36%	88,12%	96,60%
5	Angka infeksi daerah operasi	<1.5%	0%	0,89%	1,19%	0%	0,00%	0,00%							0,35%	0,69%	0,00%
6	Kepatuhan penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	100%	52,46%	87,50%	97,14%	95%	100,00%	88,00%							86,68%	79,03%	94,33%
7	Kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam	0 kejadian	0	0	0	0	1	0,00%							0,16667	0	0,333333
8	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	100%	55,24%	63,69%	60%	79,50%	72,75%	86,09%							69,55%	59,64%	79,45%
9	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	100%	87,10%	83%	90,91%	97,31%	84,42%	90,91%							88,55%	85,05%	90,88%
10	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	100%	47,13%	58,53%	59,26	56,67%	75,85%	78,54%							62,66%	54,97%	70,35%
11	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh	100%	1,24%	1,37%	9,52%	11,90%	7,14%	16,67%							7,97%	4,04%	11,90%
12	Edukasi kelompok terkait PPI	100%	27,28%	47,22%	55,88%	44,44%	44,12%	50,00%							45,75%	43,46%	48,04%

BAB IV.

PEMBAHASAN KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI

- 6.1 Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 6.1.1 Monitoring Kewaspadaan Isolasi
- a. Kewaspadaan Standart
- a) Lingkungan Rumah Sakit
- Gambar 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.1 diketahui bahwa rerata lingkungan rumah sakit di bulan Juni 2025 sebesar 86,24% dan belum mencapai standart 80%.

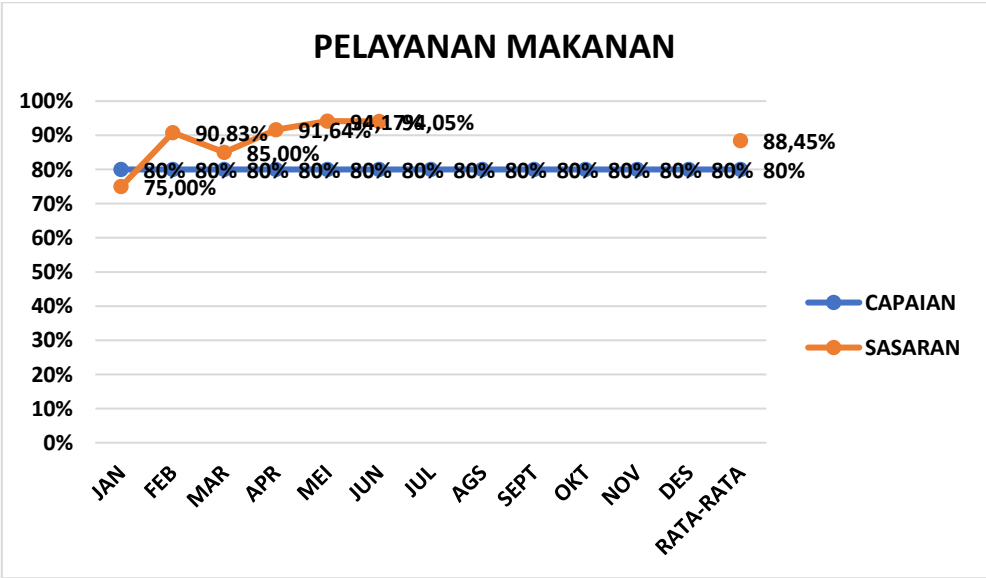
Tabel 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit

PROBLEM	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 72,35%, jauh di bawah target 80%.
STEP	Monitoring berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan di area rumah sakit.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit hingga minimal 80% sesuai target pada semua bulan berjalan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya kepatuhan staff dalam menjaga kebersihan area kerja b. Pengawasan atau audit tidak berjalan setiap hari c. Tidak tersosialisasi dan tidak diterapkannya SOP terkait kebersihan lingkungan RS d. Kurangnya motivasi atau reward bagi petugas kebersihan yang berdinass 4. Tindakan

	a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan (baik secara mingguan dan memberikan umpan balik) b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Menyusun ulang dan menyebarkan SOP kebersihan area rumah sakit e. Mengadakan pelatihan untuk petugas kebersihan dan staff terkait f. Menyediakan cheklist kebersihan harian
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	1. Nilai kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 86,24% dengan rerata sebesar 72,35% dan belum mencapai sasaran 80%. 2. Monitoring capaian kepatuhan setiap minggu 3. Lakukan perbandingan hasil kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan dengan bulan sebelumnya 4. Evaluasi area dengan peningkatan dan penurunan 5. Survei kepuasan staff dan petugas terhadap sistem baru
ACTION	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart 2. Beri feedback pada hasil temuan 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit dengan SOP dan audit sebagai standar rutin 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan SOP dan audit sebagai standar rutin

b) Pelayanan Makanan

Gambar 4.1.1.2 Pelayanan Makanan



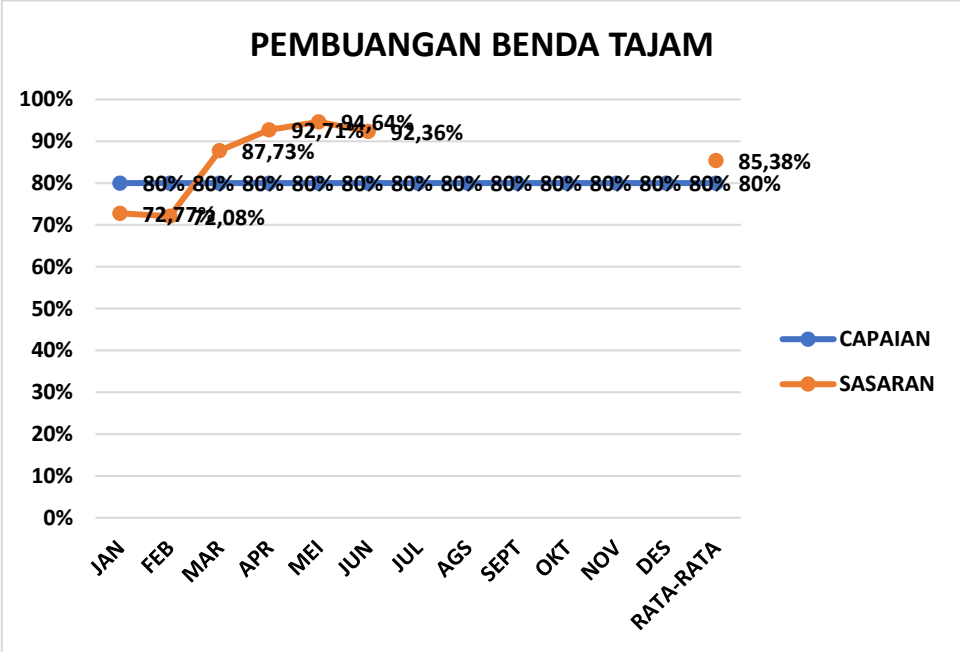
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.2 diketahui bahwa rerata pelayanan makanan di bulan Juni 2025 sebesar 94,05% dan sudah mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.2 Pelayanan Makanan

PROBLEM	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 80% dan sudah mencapai target 80%.
STEP	Memonitor kelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pelayanan makanan di area rumah sakit untuk mencegah dan mengendalikan penularan infeksi yang dapat diperoleh dari asupan gizi yang berada di lingkungan rumah sakit.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan mutu pelayanan makanan di rumah sakit agar mencapai target minimal 80% setiap bulannya. 2. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya control kualitas makanan sebelum distribursi b. Kurangnya koordinasi antara dapur dan pelayanan pasien c. Tidakpatuhnya staff dalam melakukan HH dan penggunaan APD 3. Tindakan a. Evaluasi alur kerja distribusi makanan b. Pelatihan ulang petugas gizi dan dapur terkait standart pelayanan makanan c. Pengadaan cheklist control kualitas makanan sebelum distribusi d. Monitoring harian dan evaluasi mingguan terhadap pelayanan makanan
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	1. Nilai kepatuhan pelayanan makanan bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 94,05% dengan rerata sebesar 80% dan sudah mencapai target 80%. 2. Analisis hasil monitoring harian dan evaluasi mingguan 3. Lakukan perbandingan hasil bulan berjalan dengan bulan sebelumnya 4. Identifikasi untir atau waktu yang masih mengalami kendala dalam pelayanan makanan
ACTION	1. Beri <i>feedback</i> hasil temuan 2. Koordinasi dengan CS <i>pantry</i> terkait kebersihan ruang dapur dan gizi 3. Monitoring kebersihan tangan dan penggunaan APD di dapur melalui supervise dan lembar audit 4. Terapkan system reward untuk unit atau staff dengan pelayanan terbaik 5. Lanjutkan pemantauan dan penyesuaian system pelayanan makanan sebagai bagian dari standar rutin

c) Pembuangan Benda Tajam

Gambar 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.3 diketahui bahwa rerata pembuangan benda tajam di bulan Juni 2025 sebesar 92,36% dan sudah mencapai standart 80%.

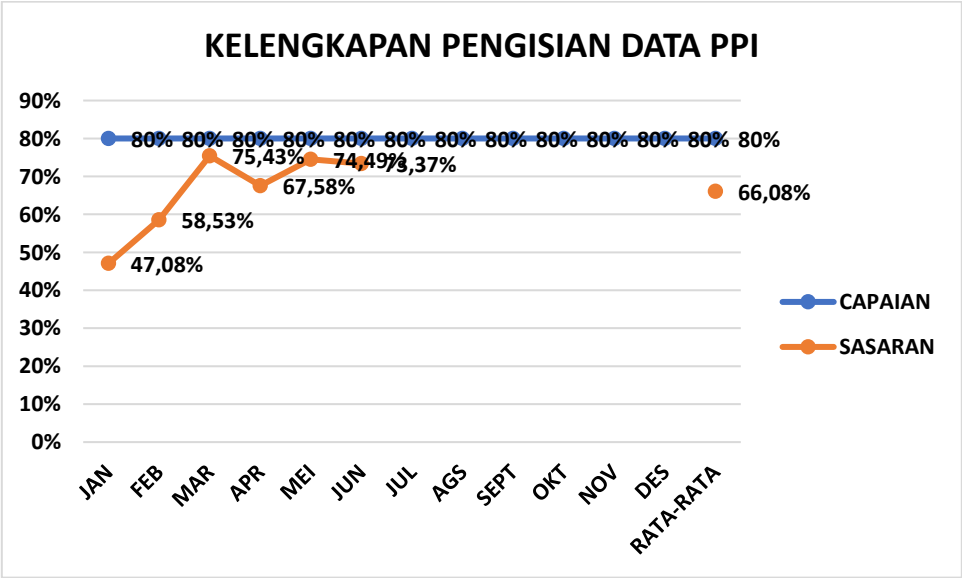
Tabel 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam

PROBLEM	Persentase kepatuhan pembuangan limbah benda tajam belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pembuangan jarum dan benda tajam untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertusuk jarum pada petugas.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pembuangan benda tajam agar mencapai target minimal 80% setiap bulan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pembuangan sampah jarum dan benda tajam di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya pemahaman staff tentang prosedur pembuangan benda tajam yang benar b. Tidak tersedianya tempat pembuangan benda tajam di area kerja (troli injeksi, troli tindakan) c. Pengawasan yang bekum optimal terhadap praktik pembuangan limbah medis tajam 4. Tindakan a. Melakukan audit pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara

	berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pembuangan jarum dan benda tajam di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit. d. Menyediakan safety box diseluruh titik layanan e. Lakukan pelatihan ulang kepada seluruh staff pelayanan terkait pembuangan benda tajam yang aman f. Lakukan review ulang SOP pembuangan benda tajam atau lakukan pembuatan dan penempatan poster diarea strategis
DO	Kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	1. Rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 92,36% dengan rerata 85,38% dan belum mencapai target 100%, 2. Evaluasi mingguan dari pelaporan IPCLN unit 3. Bandingkan data kepatuhan bulan berjalan dengan sebelumnya 4. Identifikasi unit dengan kendala dalam penerapan SOP
ACTION	1. Review kepada staf terkait pembuangan jarum dan benda tajam. 2. Lakukan <i>supervise</i> terhadap jumlah stok <i>safety box</i> di area pelayanan yang ditunjukkan dengan bukti <i>spreedshet</i> jumlah kebutuhan dan jumlah pemakaian di all lantai 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran saat melakukan monitoring pembuangan jarum dan benda tajam di unit.

d) Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

Gambar 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans



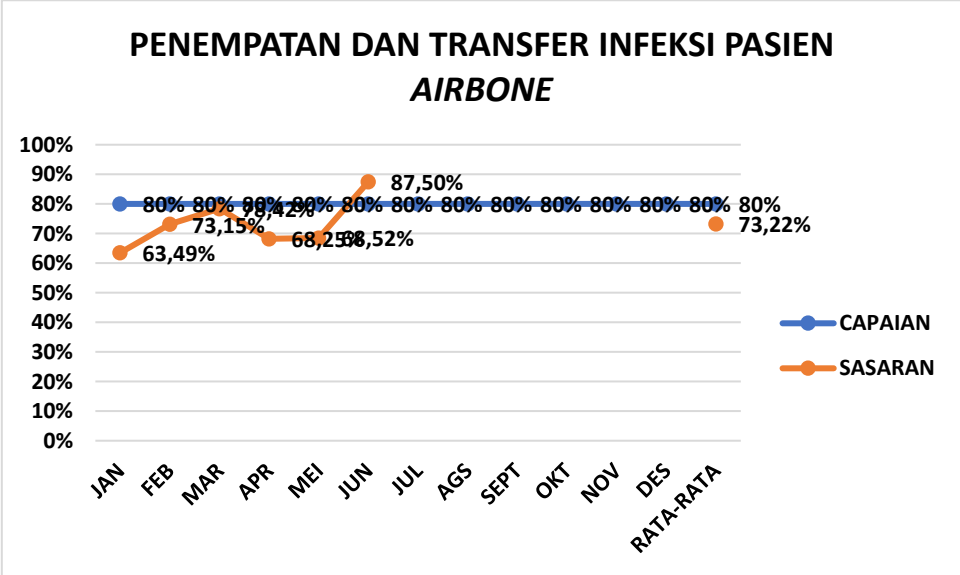
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata kelengkapan penginputan data surveilans di bulan Juni 2025 sebesar 73,37% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

PROBLEM	Persentase kelengkapan penginputan data surveilans bulan Juni tahun 2025 sebesar 73,37% dan belum memenuhi target 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring 11 kewaspadaan transmisi serta kewaspadaan isolasi.
PLAN	- Rencana: Meningkatkan kelengkapan pengisian data pencegahan dan pegendaian infeksi hingga mencapai target minimal 80% setiap bulan - Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara <i>real time</i> dan <i>ontime</i> sehingga target kepatuhan dapat tercapai. - Analisa penyebab potensial - Kurangnya pemahaman staff tetang pentingnya pencatatan data PPI - Format pencatatan yang banyak yang harus di isi oleh PJ unit - Tidak adanya system monitoring pengisian data secara rutin - Tindakan - Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo - Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring 11 kewaspadaan standart serta kewaspadaan isolasi - Memberikan pelatihan kepada seluruh staff terkait pengisian data - Monitoring mingguan oleh tim PPI terhadap pengisian data
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans belum mencapai target 80%.
STUDY	- Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di bulan Juni 2025 sebesar 73,37% dengan rerata 66,08% dan belum memenuhi standart 80% - Lakukan survei terhadap staff untuk mengetahui hambatan dalam pengisian - Bandingkan tingkat kelengkapan data bulan berjalan dengan bulan sebelumnya
ACTION	- Lakukan evaluasi pengisian form PPI by web setiap bulan - Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi dengan

	melibatkan Karu dan Kabid terkait. 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faham 4. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 5. Perbaiki format atau system pengisian berdasarkan masukan staff 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan
--	--

- b. Kewaspadaan Transmisi
- a) Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*
- Gambar 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer infeksi pasien *airbone* di bulan Juni 2025 sebesar 87,50% dengan rerata yang belum mencapai standart 80%.

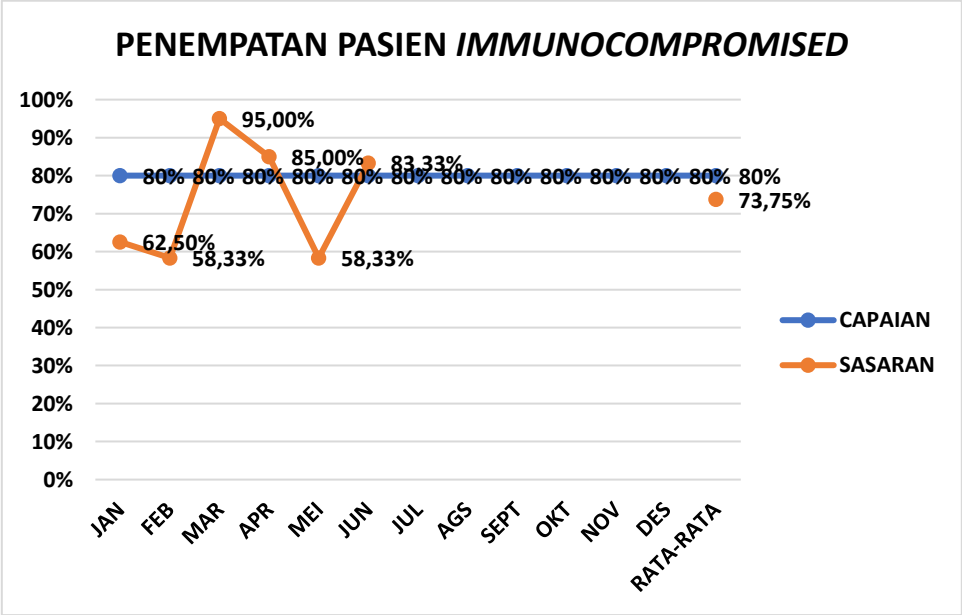
Tabel 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkesi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan dan transfer pasien dengan infeksi airborne agar mencapai target minimal 80%

	- Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Analisa penyebab potensial ; - Kurangnya pemahaman staff mengenai prosedur <i>airbone</i> precaution - Tidak semua ruang perawatan dilengkapi system isolasi <i>airbone</i> - Koordinasi antar unit dalam proses transfer masih lemah - Tindakan - Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sesuai dengan SOP dan standart yang berlaku - Koordinasi dengan IPCLN melalui grub komunikasi aktif di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STUDY	- Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 87,50% dengan rerata capaian 73,22% dan belum mencapai target 80%, - Monitoring kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dilakukan secara mingguan - Evaluasi dilakukan terhadap proses transfer yang terjadi setiap bulan - Lakukan audit terhadap dokuementasi penempatan pasien
ACTION	- Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. - Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi - Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) - Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi,

	5. Perkuat system pemantauan dan laporan internal 6. Beri pelatihan sebagai agenda rutin tiap semester 7. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, 8. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat
--	--

b) Penempatan Pasien *Immunocomprised*
 Gambar 4.1.1.6 Penempatan Pasien *Immunocomprised*



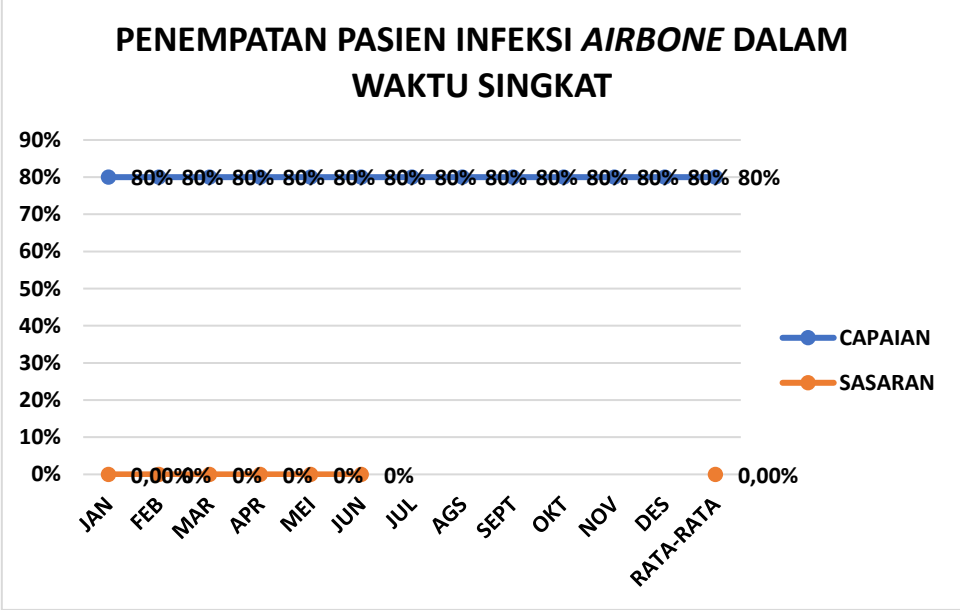
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien *immunocomprised* di bulan Juni 2025 sebesar 83,33% dengan rerata belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.5 Penempatan Pasien *Immunocomprised*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan pasien immunocompromised sesuai standart dengan target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial; b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya penempatan khusus bagi pasien immunocompromised

	c. fasilitas ruang isoalsi terbatas d. kelemahan dalam system triase awal dan komunikasi lintas unit 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> terhadap proses triase d. Optimalisasi ruang perawatan dengan system kohorting pasien sejenis
DO	Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 83,33% dengan rerata 71,75% dan belum mencapai standart 80%. 2. Lakukan audit internal mingguan terhadap dokumentasi dan praktik penempatan 3. Data dievaluasi untuk melihat perbaikan dan hambatan dalam proses 4. Lakukan pembahasan secara rutin dalam rapat koordinasi
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Evaluasi keberlanjutan program setiap 3 bulan dan perbaikan berkelanjutan 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>

- c) Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat
- Gambar 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan Juni 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat

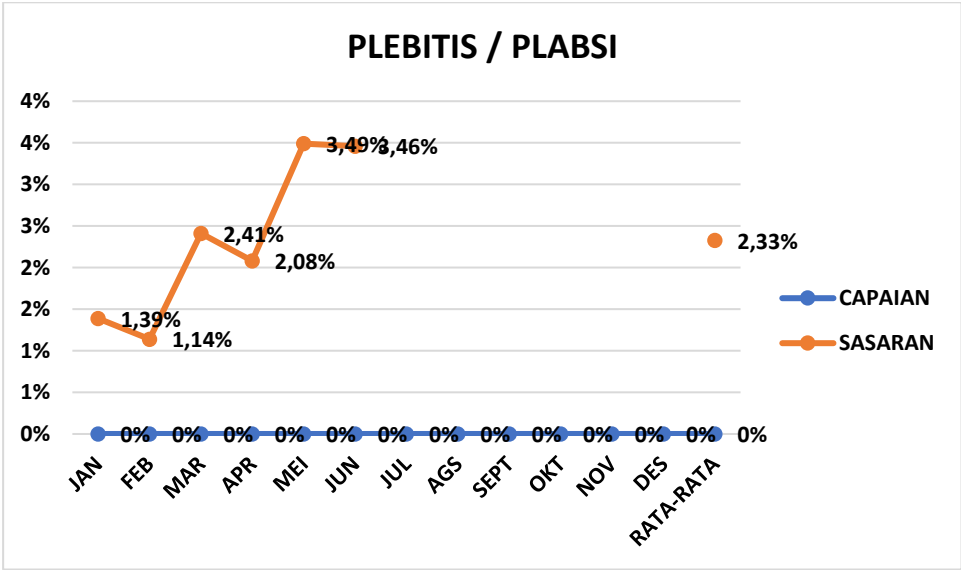


	baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 0%, 2. Ditemukan data sebesar 0% dikarenakan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat tidak adapat terukur secara <i>real time</i>
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.

6.1.2 Audit *Bundle* HAI's PPI

a. *Bundle Phlebitis*

Gambar 4.1.2.1 Phlebitis



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan Juni 2025 sebesar 3,46% dan belum mencapai standart 0%.

Tabel 4.1.2.1 Phlebitis

No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	4
		IRNA 2B	2
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
2	Februari	IRNA 3A	0
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	6
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	1
		ICU	0
3	Maret	IRNA 3A	6
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	6
		IRNA 2B	4
		MATERNITAS	2
		NEONATOLOGI	2
		ICU	0
		IRJA	7
4	April	IRNA 3A	15
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	3
		IRNA 2B	7
		NEONATOLOGI	1
		IRJA	2
5	Mei	IRNA 3A	19
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	26

		NEONATOLOGI	0
		MATERNITAS	0
		IRJA	0
6.	Juni	IRNA 3A	9
		IRNA 3B	9
		IRNA 2A	10
		IRNA 2B	17
		MATERNITAS	2
		NEONATOLOGI	2
		ICU	2
TOTAL			212

Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui kejadian plebitis terbanyak di unit IRNA 2B sebesar 17 kejadian.

Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

PROBLEM	Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	- Rencana: Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi $\leq 1\%$ dalam 3 bulan . - Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit. - Akar masalah yang diidentifikasi; - Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus - Lama pemasangan infus >72 jam - Kurangnya pencatatan dan monitoring harian - Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis - Tindakan - Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus - Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus - Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam - Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.
STUDY	Data kejadian phlebitis pada bulan Juni sebesar 3,46% dengan rerata 2,33% dan belum mencapai target 0%

	2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika angka tetap tinggi; a. Evaluasi Kembali penyebab utama b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan c. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan

Link rekap Plebitis PPI 2025 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XjGil_YwmlziDYeUHxce3xvO36M89OqWvYhlgKjDDWE/edit?usp=sharing

Gambar 4.1.2.1 Bundle IDO

 PT. DISA PRIMA MEDIKA			LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2025															 PT. DISA PRIMA MEDIKA						
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Inisial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl/Uam MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi	Di Operasi & Tindakan Operasi	Tim Operasi					Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Asesmen lain	Praduga Penyebab ILO	RTL	Total Kejadian IDO
											Ast Op	dr-An	Ast. An	Instrumen	Onloop			Saat Op	Saat IDO					
Januari																								
Februari																								
1	2/12/2025	NY ZHILA QITRIYAH	113869	POLI OB/GYN	27 TH	2/4/2025	DR. SANTOSO	BPJS KLS 1	2/4/2025	STP0480 UK 40-41 M03 OG SEVERE OUBO OG LETAK OBLIG + LITATAN TALU PUSAT	EDO	HARLI	RIZKI	KIKIS	SILFI	-	Ada rembesan di area talutan, terdapat pusih dan berbau tidak sedap	HB : 12,2 L : 5.400 T : 198.000	-	VIT C 2X1 ONQWA 1X1	-	Obesitas 55kg ke 93 kg	MEJAGA BALUTAN LUKA ASAR TETAP KERING BILA TERJADI REMBESAN MAHA GIGANTI MAKAN YANG BANYAK TIDAK BOLEH TARAK MENURUNKAN BB ATAU MENJAGA BB	1
2	2/28/2025	NY KHOIRO UMAH	081524	2B	54 TH	1/16/02/2025 1/26/02/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 3	1/16/02/2025 1/26/02/2025	1 APPENDICITIS AKUT II LEUS OBSTRUKTIF	KIKIS EDO	BOBI HERU	ROHMAN ASUNG	ENJO ANTOK	DANANG SILFI	Kontrol poli ke 1 post MRS pertama tanggal 21/02/2025 MRS ulang tanggal 28/02/2025 Kontrol poli ke 1 post MRS ke dua tanggal 06/03/2025	Rawat luka terbuka	OP KE 1 Hb 12,4 L 8.800 T 243.000 GOS 340 OP KE 2 Hb 11,5 L 23.100 T 462.000 GOS 428	-	Rantisin 3x1 Ondani 3x1 Santagess 3x1 Metronidazole 3x1 Memprenem 3x1	Obat KRS Cefixin 2x200 mg Etorix 2x1 OMZ 2x1 Batafil 1x1	GDA tinggi	RL luka khusus oleh tenaga ahli Diet DM Penggunaan obat-obatan harus di minum secara teratur Rawat luka tap 2 hari sekali di RS PHS	2
Maret																								
1	3/5/2025	RUL WIDARAT	113870	POLI BEDAH	34 TH	2/27/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/27/2025	S. APPENDICITIS AKUT	EDO	BOBI	ASUNG	KIKIS	DANANG	Kontrol I 05/03/2025	-	Hb 14,1 L 11.700 T 243.000 GOS 118	-	Obat post kontrol poli Cefem 2x100 Ibu profen 2x100 OMZ 2x1	Rawat luka bersih mengunahan outbal Banyak luka nembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Diet yang dikonsumsi kurang (protein) Konsumsi air putih kurang	Rawat luka bersih di rumah dengan saran NS Banyak mengkonsumsi protein hewani Banyak melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat) Lakukan kompres hangat bila demam	3
2	3/5/2025	FARIDA NURDIANA	035075	POLI BEDAH	46 TH	2/24/2025	DR. RIPTA	BPJS KLS 3	2/25/2025	S. APPENDICITIS AKUT + S. CHOLELITIASIS	WAFI	HARLI	RIZKI	FENDRA	NIKOL	Kontrol I 05/03/2025	-	-	Obat post kontrol Thiamphenicol 4x1 Setiap luka nembes wajib di ganti	Rawat luka bersih Setiap luka nembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Diet yang dikonsumsi kurang (protein) / banyak makan	Rawat luka bersih di rumah dengan saran NS Banyak mengkonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	4	
3	2/7/2025	RATNA DEWI	090619	POLI BEDAH	42 TH	2/23/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/24/2025	MAMAE ABRERAN D / EKOISI	WAFI	HERU	ROHMAN	FENDRA	DANANG	Kontrol I 28/02/2025 Kontrol II 07/02/2025	Keluar cloth pada saat kontrol ke dua	Hb 12,9 L 5.800 T 185.000 Hasil PA : Jinak	keluar gumpalan darah di ketak "area insai"	Ibu profen 2x1 Cefem 2x100 mg	Luka tidak di jahit, di tampon menggunakan kasa Luka diberikan outbal, dan ditutup bisa dijahit	Kurangnya mobilisasi	Rawat luka tap 2 hari sekali. Luka yang di aff jahitan diben dan di tampon kasa Evaluasi kembali 14/03/2025	5

LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2025										PT. DISA PRIMA MEDIKA														
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Instalasi Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl Ujian MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi	Dx Operasi & Tindakan Operasi	Tim Operasi				Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Asesmen lain	Preduga Penyebab ILO	RTL	Total Kejadian IDO	
											Ast Bid	dr. An	Ast. An	Instrumen			Onkolog	Saat Op						Saat IDO
Januari																								
2	3/5/2025	FARIDA NURDIANA	025075	POU BEDAH	48 TH	2/34/2025	DR. RIFTA	BPJS KLS 3	2/25/2025	S. APPENDICITIS AKUT + S. CHOLELITIASIS	WAFI	HARU	RIZKI	FENDRA	NIKO	Kontrol I 25/03/2025	-	-	-	Obat post kontrol Thiamphenicol 4x1 Metronidazole 2x1 Asam Mefenamat 2x1	Rawat luka bersih Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Diet yang dikonsumsi kurang (protein) / tidak makan	demam	4
3	3/7/2025	RATNA DEWI	060019	POU BEDAH	42 TH	2/23/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/24/2025	MAMAE ABRERAN D / ENOSIS	WAFI	HERU	ROHMAN	FENDRA	DANANG	Kontrol I 26/02/2025 Kontrol II 07/02/2025	Keluar droth pada saat kontrol ke dua	Hb 12,9 L 5.900 T 165.000 Hasil PA : Jinak	keluar gumpalan darah di ketiak "area insisi"	Ibu profen 2x1 Cefixim 2x100 mg	Luka tidak di jahit, di tampon menggunakan kasa Luka diberikan subsal, dan ditutup kasa steril	Kurangnya mobilisasi	Rawat luka sap 2 hari sekali, Luka yang di aft jahitan diberi dan di tampon kassa Evaluasi kembali 14/03/2025	5
4	5/24/2025	LUTFIANWISSEH	001606	RMA DA	35 TH	3/23/2025	DR. SANTOSO DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	3/12/2025	MIDOMA UTERI	EDO	HARU	RIZKI	ERD	NIKO	Kontrol I 25/03/2025	Keluar pusih diantara jahitan pasien ketika di bawah ke IGO	Hb 10,1 L 6.200 T 500.000 GOS 70 PPT 13,0 APPT 30,5 PCGT ep Hb 9,2 L 10.500 T 567.000	Hb 10,3 L 16.100 T 540.000	Ceftriaxon 2x1 Metronidazol 3x1 Santagesik 3x1 Ranitidin 2x1 Obat TB Ritampirin 0-0-400mg Pisicarnamid 0-0-500mg Isoniazid 0-0-1 Racklan klambutol 0-0-500mg	Rawat luka menggunakan outisel sap pagi atau bila rembes	Diet pasien kurang	Rawat luka sap pagi Konsumsi obat TB	6
April																								
Mai																								
Juni																								
1	6/17/2025	SOHFA	121438	POU OB/GYN	45 TH	6/2/2025	DR. SANTOSO	BPJS KLS 3	6/4/2025	TUMOR PERVAGINA	WAFI	HARU	RIZKI	FENDRA	NIKO	Kontrol I 26/06/2025	jahitan basah	Hb : 12,4 L : 12.800 T : 310.000	-	Orinosa 1x1 Aamrel 2x1	Rawat luka dan ganti perban setiap rembes	Diet pasien kurang (tidak tinggi protein)	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	7
Juli																								
Agustus																								
September																								
Oktober																								
November																								
Desember																								

Interpretasi : Berdasarkan gambar 4.1.2.3 dapat diketahui jumlah Bundle IDO di bulan Juni 1 kasus pada pasien Laparatopi dengan diagnonas Tumor Pervagina.

Link Rekap analisa IDO 2025 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-oovztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true

Tabel 4.1.2.3 PDSA Bundle IDO

PROBLEM	Persentase kejadian IDO dengan rerata 0,39% dan belum mencapai standar 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IRJA, IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian IDO untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian IDO menjadi <0,2% dalam 3 bulan kedepan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian IDO dan dapat menurunkan kejadian IDO di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Kepatuhan aseptis saat operasi belum maksimal b. Sterilisasi alat belum diaudit secara menyeluruh c. Antibiotic profilaksis tidak diberikan tepat waktu d. Monitoring luka pascaoperasi belum optimal 4. Tindakan a. Penegakkan protokol aseptis secara ketat (5 momen kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan penggunaan APD yang sesuai) b. Pemberian antibiotic profilaksis 30-60 menit sebelum insisi c. Audit sterilisasi alat operasi d. Monitoring luka operasi dan edukasi pasien post-op
DO	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0% dengan menerapkan, 1. Terapkan system cheklist pre-op untuk memastikan pemberian antibiotic dan sterilisasi 2. Lakukan pelatihan ulang tim bedah dan perawat mengenai protocol pencegahan IDO 3. Audit harian pada ruang operasi dan rawat inap pasca-operasi 4. Edukasi psien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah
STUDY	1. Data kejadian IDO pada bulan Juni sebesar 1 kejadian dengan rerata kejadian 0,40% dan belum mencapai target 0% 2. Tinjau tren angka IDO setiap minggu 3. Lakukan evaluasi melalui audit kepatuhan prosedur dan insiden harian 4. Identifikasi apakah terjadi penurunan kejadian dan kepatuhan meningkat
ACTION	1. Jika angka IDO menurun : terapkan prosedur sebagai standar dan teruskan monitoring

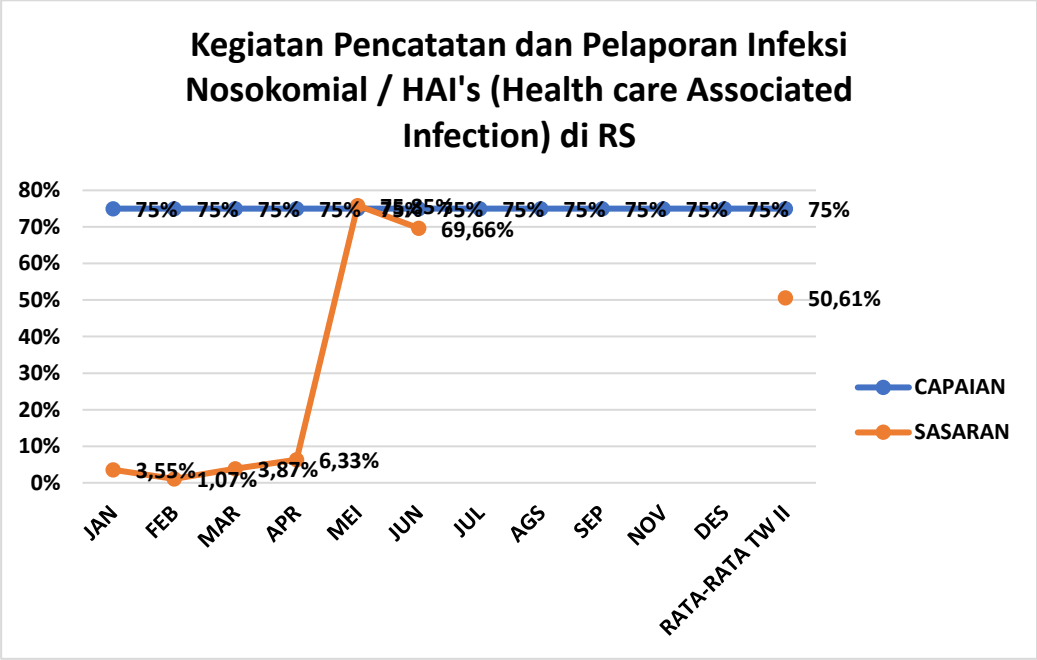


	2. Jika belum berhasil maka, a. Perbaiki SOP sesuai temuan lapangan b. Tambah frekuensi supervise dan audit c. Evaluasi kinerja individu yang tidak patuh dan lakukan pembinaan
--	--

6.1.3 Mutu PPI

a. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

Gambar 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.1 diketahui bahwa rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan Juni 2025 sebesar 69,66% dengan rerata belum mencapai standart 75%.

Tabel 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

PROBLEM	Persentasi kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan HAI's mencapai 90% kelengkapan data dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah, a. Ketidaktahuan peugas tentang format pelaporan HAI's b. Kurangnya pemantauan dari tim IPCN/IPCLN c. Sistem pencatatan sudah digital namun staf masih tidak patuh d. Beban kerja tinggi, menyebabkan pencatatatn tidak menjadi prioritas 4. Tindakan a. Pelatihan ulang tentang HAI's dan pentingnya



	pelaporan b. Distribusi ulang format pelaporan yang mudah dipahami c. Monitoring mingguan dari IPCN ke setiap unit
DO	Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 80% dan akan dilakukan, 1. Lakukan sosialisasi dan pelatihan awal dalam 1 minggu pertama 2. Terapkan system pelaporan mingguan berbasis google form (by link : https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo/home) 3. IPCN melakukan validasi data mingguan selama 3 bulan 4. Berikan umpan balik kepada unit dengan Tingkat pelaporan rendah
STUDY	1. Rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 69,66% dengan rerata 50,61% dan belum mencapai target 75% 2. Bandingkan Tingkat kelengkapan dan ketepatan laporan HAIs antar unit 3. Liat tren pelaporan : apakah meningkat dari minggu ke minggu? Adakah perubahan dari bulan sebelumnya? 4. Identifikasi kesalahan umum dan kesenjangan pemahaman
ACTION	1. Re-sosialisasi ulang kepada staf terkait langkah pelaporan HAI's. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu all pelayanan untuk menghimbau IPCLN/PIC PPI unit untuk patuh dalam melaporkan kejadian HAI's dengan waktu perekapan selama 1 minggu sekali 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's

b. Kepatuhan Kebersihan Tangan

a) Berdasarkan Unit

Tabel 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan

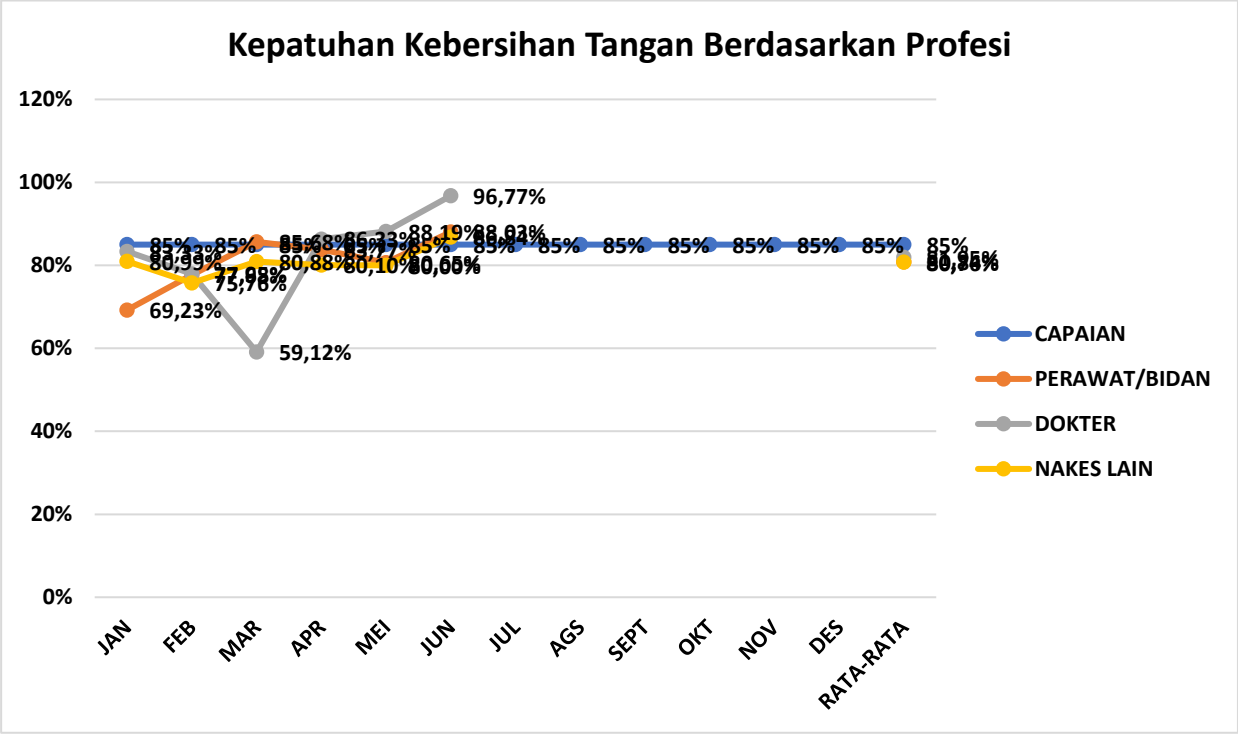
NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDAR T	BULAN												RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3A	85%	76,36%	80,77%	88,41%	82,46%	85,11%	95,83%							84,82%
2	3B	85%	87,50%	44,44%	41,43%	86,96%	85,03%	71,05%							69,40%
3	2A	85%	100%	50,00%	71,34%	77,91%	69,03%	86,67%							75,83%
4	2B	85%	100%	100%	78%	77,91%	73,12%	80,85%							84,98%
5	2D	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%
6	MAT	85%	80%	71,79%	68%	86,67%	92,47%	94,00%							82,19%
7	NEO	85%	72,73%	89,02%	96%	88,79%	93,55%	96,81%							89,43%
8	ICU	85%	100%	100%	75%	75%	100,00 %	65,00%							85,83%
9	IKO	85%	100%	44,44%	0%	75%	46,15%	0,00%							44,27%
10	IGD	85%	58,57%	77,78%	84%	82,35%	80,49%	94,59%							79,59%
11	IRJA	85%	100%	78,23%	83%	84,40%	86,96%	79,07%							85,24%
12	CS	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%
13	As. Center	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%
14	Farmasi	85%	100%	72,41%	0%	88,10%	87,36%	100,00 %							74,65%
15	Laboratorium	85%	100%	100%	94%	88,51%	0,00%	0,00%							63,71%
16	Radiologi	85%	0%	100%	0%	77,78%	100,00 %	100,00 %							62,96%
17	Gizi dan Dapur	85%	62,50%	78,26%	97%	84,72%	86,65%	88,41%							82,95%
18	RM / PDF	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%
19	CSSD	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%

20	LAUNDRY	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%
----	---------	-----	----	----	----	----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.2 diketahui kepatuhan kebersihan tangan pada bulan Juni 2025 tertinggi berada pada unit Neonatologi dengan rerata 89,41%.

b) Berdasarkan Profesi

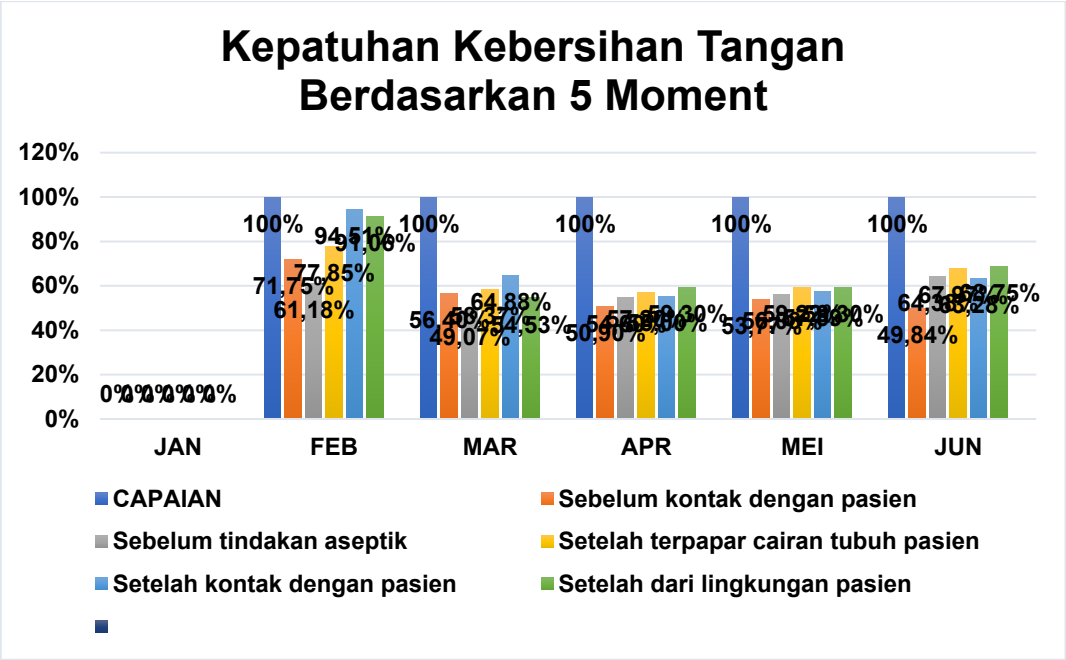
Gambar 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan Juni 2025 sebesar tertinggi pada profesi Dokter dengan rerata 81,55%.

c) Berdasarkan 5 Moment

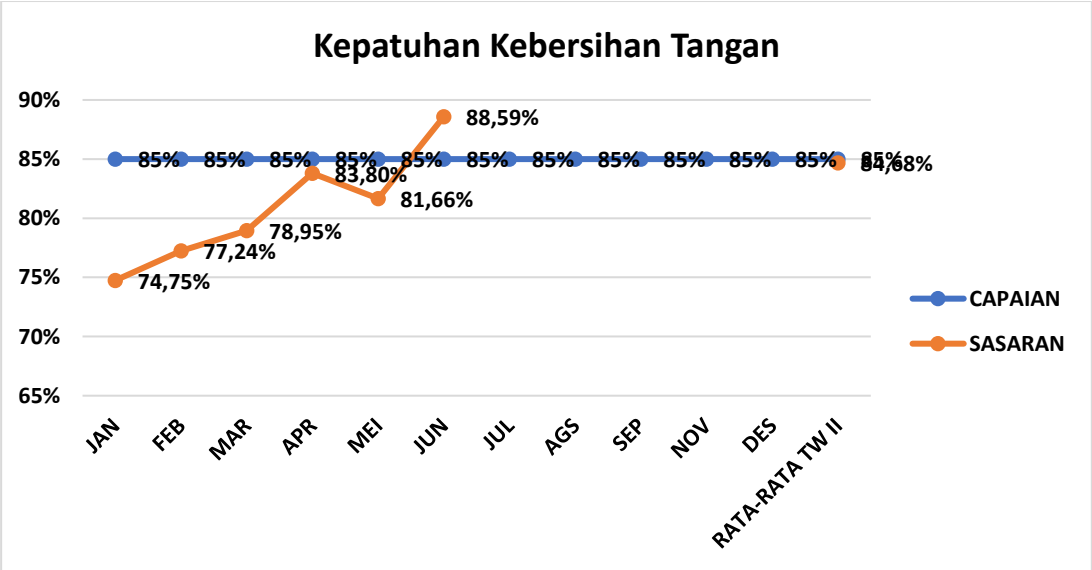
Gambar 4.1.3.2.1



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 moment di bulan Juni 2025 sebesar

- Sebelum kontak dengan pasien sebesar 49,84%
- Sebelum tindakan aseptik sebesar 64,38%
- Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67,97%
- Setelah kontak dengan pasien sebesar 63,28%
- Setelah dari lingkungan pasien sebesar 68,75%

Gambar 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.3 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan Juni 2025 sebesar 88,59% dengan rerata belum mencapai target 85%.

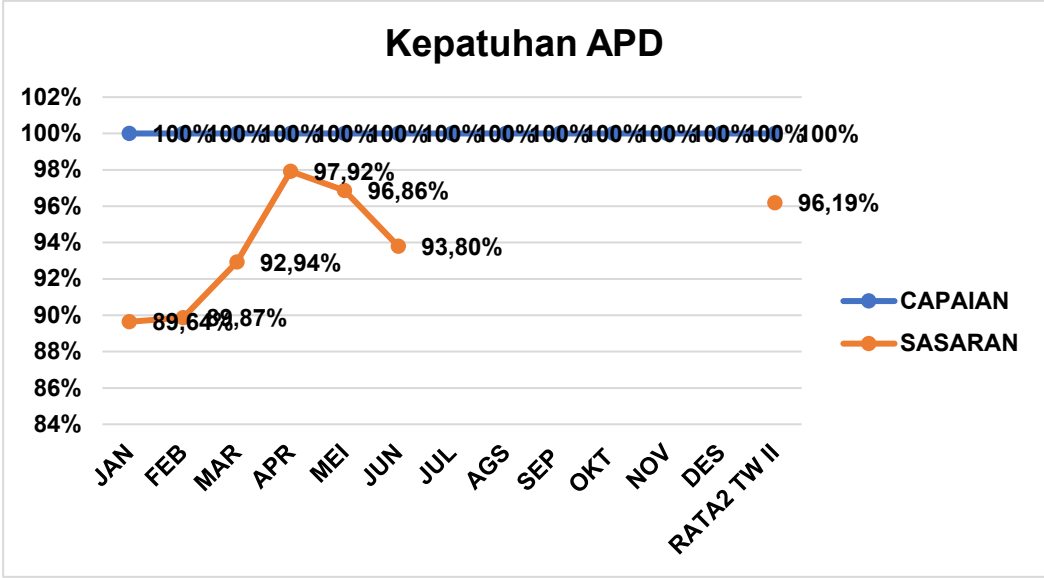
Tabel 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan

PROBLEM	Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan Juni tahun 2025 sebesar 88,59% dengan rerata belum mencapai target belum memenuhi target ≥85%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mencapai kepatuhan minimal 90% dalam 3 bulan dan mempertahankan minimal 85% secara berkelanjutan 2. Harapan Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya momen 5 cuci tangan WHO b. Ketersediaan handrub yang belum merata c. Supervise dan feedback belum dilakukan rutin d. Ketergantungan pada pengingat eksternal tidak menjadi kebiasaan 4. Tindakan a. Membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar

	b. Audit harian oleh IPCN dengan feedback mingguan c. Manfaatkan poster, QR-code edukasi vidieo, dan pengingat audio di area kritis d. Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan e. Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk staf lama f. Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi.
--	--

g. Kepatuhan APD

Gambar 4.1.3.4 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan Juni 2025 sebesar 93,80% dengan rerata belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.4 Kepatuhan APD Berdasarkan Unit

INDIKATOR PENILAIAN	BULAN												RATA- RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3A	88,00%	100,00%	93,10 %	95,15%	100,00%	100,00%							96%
3B	100,00%	90,00%	96,77%	100%	100,00%	100,00%							98%
2A	33,33%	100,00%	98,04%	100%	100,00%	100,00%							89%
2B	100,00%	100%	98,77%	100%	100%	100,00%							100%
2D	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%							0%
MAT	88,00%	100%	97,22%	100%	100%	100,00%							98%
NEO	88,89%	100%	100%	100%	100%	100,00%							98%
ICU	100,00%	100%	79,17%	45,45%	0%	100,00%							71%
IKO	100,00%	100%	0%	0%	100%	0,00%							50%
IGD	98,65%	100%	100%	100%	100%	100,00%							100%
IRJA	100,00%	89%	98,98%	100%	100%	100,00%							98%
CS	27,27%	100%	0%	0%	0%	0,00%							21%
As. Center	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%							0%
Farmasi	100,00%	100%	0%	100%	100%	100,00%							83%
Laboratorium	83,33%	56%	52,38%	84,62%	0%	0,00%							46%
Radiologi	60,00%	0%	66,67%	100%	100%	0,00%							54%
Gizi dan Dapur	83,33%	76%	81,16%	100%	81%	65,22%							81%
RM / PDF	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%							0%
CSSD	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%							17%
LAUNDRY	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%							16,67%
B3	87,72%	93,75%	83,33%	100%	100,00%	100,00%							94,13%
LAIN-LAIN	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%							0,00%

Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD berdasarkan di Unit di bulan Juni 2025 tertinggi di unit IRNA 2B dan IGD.

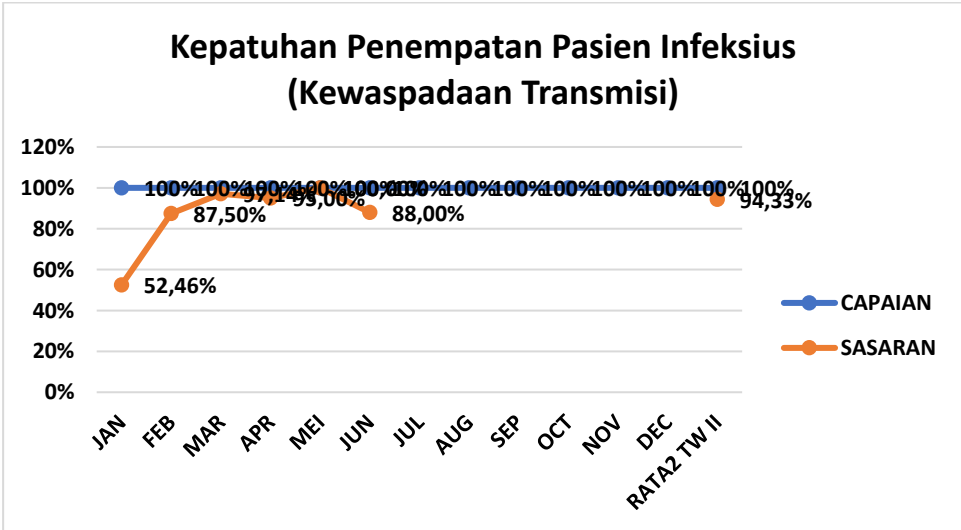
Tabel 4.1.3.5 Kepatuhan APD

PROBLEM	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mempertahankan kepatuhan APD di level 100% secara konsisten dalam 6 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah potensial a. Ketidaknyamanan dalam penggunaan APD (panas, pengap, dll) b. Persepsi bahwa risiko infeksi menurun sehingga kepatuhan bisa longgar c. Ketidakteraturan dalam pengawasan langsung di unit 4. Tindakan a. Memberikan pengingat visual di area kerja (poster, stiker, digital signal) b. Supervise rutin oleh IPCN/IPCLN c. System reward bulanan unit dengan kepatuhan 100% d. Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan
DO	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan Juni tahun 2025 dengan, 1. Lakukan pemasangan materi edukasi dan pengingat di setiap unit 2. Lakukan audit dan observasi harian 3. Berikan umpan balik mingguan dan apresiasi bagi tenaga yang patuh 4. Lakukan survei kecil mengenai kenyamanan dan persepsi staff tentang APD
STUDY	1. Rerata kepatuhan penggunaan APD pada bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 93,80% dengan rerata 96,19% dan belum mencapai target 100% 2. Pantau tren kepatuhan : apakah tetap stabil di angka 100% 3. Analisa hasil audit : apabila ditemukan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan 4. Evaluasi hasil survei kenyamanan dan motivasi tenaga Kesehatan
ACTION	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Tinjau factor penyebab (missal APD tidak tersedia, tidak nyaman dalam penggunaan APD) 3. Beri feedback pada hasil temuan.

	4. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Beri reward pada unit dengan tingakt kepatuhan penggunaan APD 100%
--	--

h. Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Gambar 4.1.3.5 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



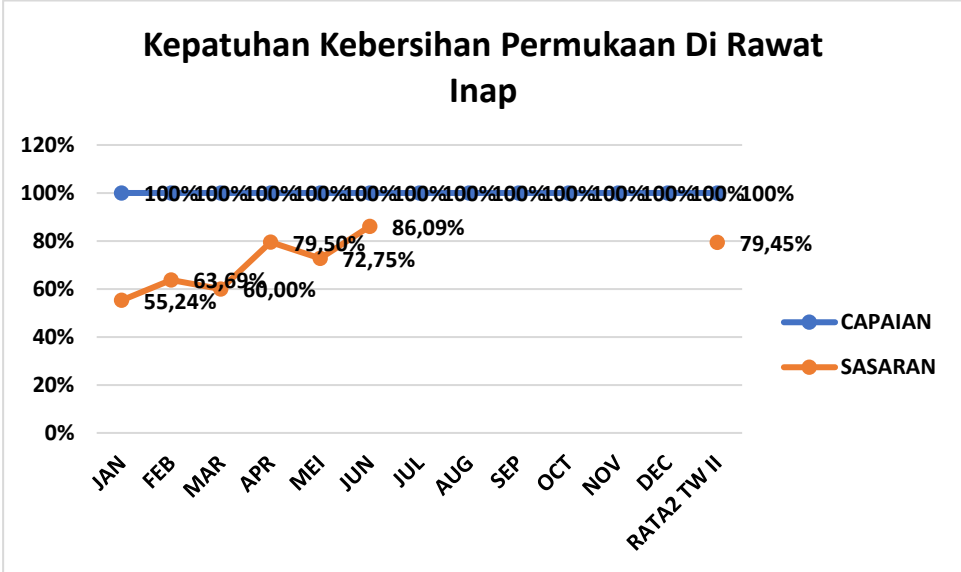
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius di bulan Juni 2025 sebesar 88% dengan rerata belum mencapai standart 100%.

Tabel 4.1.3.6 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Menajga kepatuhan 100% dalam penempatan pasien infeksius sesuai prinsip kewaspadaan transmisi selama 12 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah potensial ; a. Ketidakesuaian pemahaman tenaga jesehatan tentang klasifikasi pasien infeksius b. Sistem triase atau skrining awal tidak optimal c. Ruangn isolasi terbatas atau tidak tersedia

	disaat dibutuhkan 4. Tindakan - Refresh training tentang identifikasi pasien dengan infeksi menular dan protocol penempatannya - Standarisasi formuli triase dan SOP pemindahan pasien infeksius - Evaluasi dan optimasi ketersediaan ruang isolasi - Audit dan umpan balik harian untuk kasus penempatan pasien baru
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100% dengan melakukan, - Lakukan pelatihan ulang kepada perawat IGD, rawat inap dan IPCN - Terapkan system checklist pada form masuk pasien terkait status infeksi dan tindak lanjut - Buat system “red flag” di rekam medis pasien dengan infeksi menular - Monitoring harian oleh IPCN/IPCLN terhadap semua kasus rawat inap baru
STUDY	- Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 88% dengan rerata 94,33% dan belum mencapai target 100% - Review data audit harian atau mingguan : adakah kasus pasien infeksius tida sesuai dengan tempat? - Tinjau waktu tunggu antara identifikasi infeksius dan pemindahan pasien
ACTION	- Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius. - Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi - Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) - Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.

i. Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap
 Gambar 4.1.3.6 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap di bulan Juni 2025 sebesar 86,09% dengan rerata 79,45% dan belum mencapai target 100%.

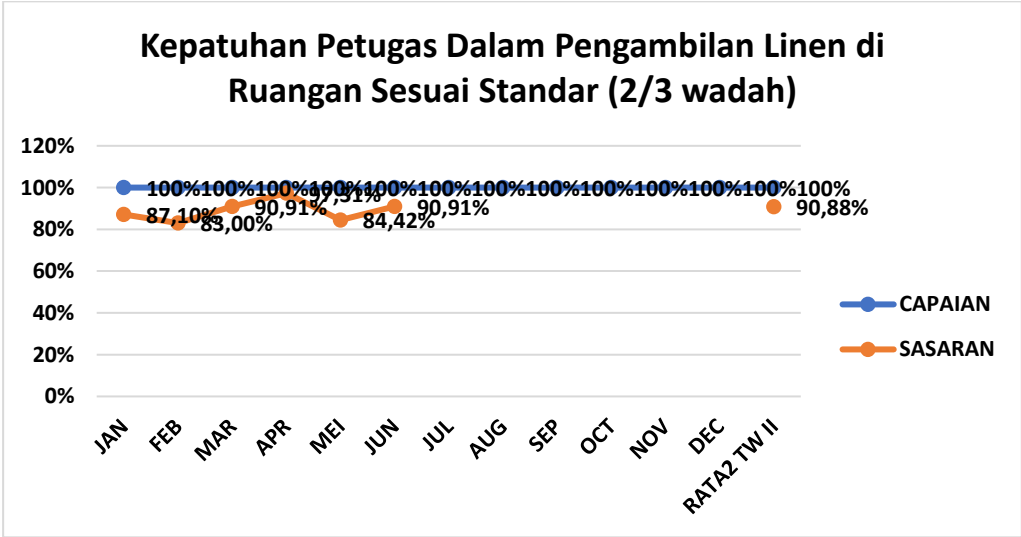
Tabel 4.1.3.7 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

PROBLEM	Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebersihan permukaan di ruang rawat inap yang dapat meningkatkan resiko infeksi nosokomial
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan kebersihan permukaan menjadi ≥90% selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah a. Petugas CS kurang terlatih atau tidak memahami area kritis b. Ketidakteraturan jadwal atau dokumentasi kebersihan c. Tidak adanya verifikasi atau audit lapangan secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Pelatihan ulang petugas CS tentang standart kebersihan permukaan khususnya area sentuh tinggi e. Pembuatan cheklist harian pembersihan permukaan di setiap ruangan (link https://drive.google.com/drive/folders/12xRPis1jwkNrO7 jobdisk :

	6kNnKCo73mgiUc51pM?usp=drive_link) 5. Sumber daya - Petugas kebersihan CS yang terlatih - Peralatan pembersih yang memadai - SOP dan panduan visual untuk kebersihan - Peningkatan supervisi lebih sering
DO	Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, - Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Menggunakan checklist untuk memastikan setiap sudut kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi - Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding - Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif - Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan - Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat
STUDY	- Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan Juni tahun 2025 yaitu sebesar 86,09% dengan rerata 79,45% dan belum mencapai target 100% - Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut, - Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta kamar mandi bau tidak enak - CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor - Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah - Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed - Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai - Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau - Metrik evaluasi yang digunakan, - Audit kebersihan kamar kosong - Audit kebersihan oleh CS - Audit kebersihan troli tindakan diruang rawat inap - Audit kebersihan di ruang IKO - Evaluasi kebersihan tirai/gorden - Penanganan linen infeksius - Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi
ACTION	- Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. - Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan

	yang berisiko tinggi
--	----------------------

- j. Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah
- Gambar 4.1.3.7 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah bulan Juni 2025 sebesar 90,91% dengan rerata belum mencapai target 100%.

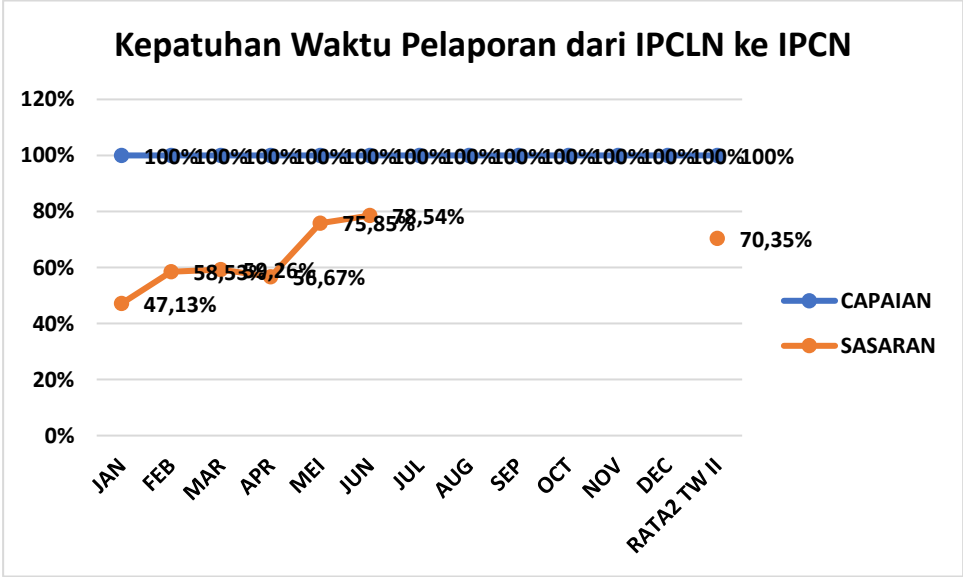
Tabel 4.1.3.8 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah

PROBLEM	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan pengambilan lienn menjadi 100% sesuai standart selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Penyebab yang diidentifikasi; a. Petugas belum paham resiko infeksi silang akibat overfilling b. Kurangnya pengawasan atau evaluasi harian c. Tidak tersedia alterbatif wadah bila kapasitas sudah 2/3 penuh d. Tidak ada system peringatan visual di wadah linen 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan.



	b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai 2/3 wadah e. Sediakan Cadangan wadah linen untuk kondisi penuh agar petugas tidak terpaksa overfill
DO	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya dengan upaya, 1. Melakukan pelatihan secara singkat kepada petugas kebersihan dan perawat tentang penanganan linen 2. Tempel stiker batas maksimal 2/3 pada semua wadah linen kotor di setiap ruangan 3. Terapkan observasi harian oleh petugas IPCN atau kepala ruangan selama satu minggu pertama 4. Catat Tingkat kepatuhan harian dan lakukan pengingat verbal jika ditemukan pelanggaran
STUDY	1. Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. 2. Evaluasi data observasi dan bandingkan dengan bulan sebelumnya 3. Lakukan diskusi mingguan dengan petugas terkait tantangan dilapangan 4. Catat perubahan tren kepatuhan dan identifikasi apakah penandaan visual
ACTION	1. Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. 4. Berikan system reward / sanksi sederhana berbasis performa petugas 5. Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor

k. Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN
 Gambar 4.1.3.8 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.8 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN bulan Juni 2025 sebesar 78,54% dengan rerata 70,53% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.9 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN

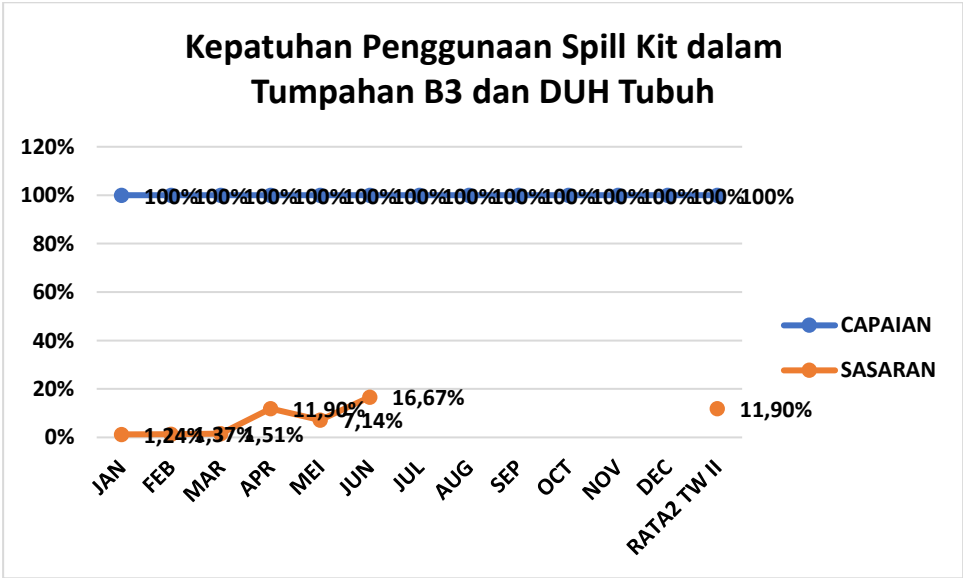
PROBLEM	Pelaporan dari IPCLN (Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Unit) ke IPCN (Petugas PPI Rumah Sakit) tidak dilakukan tepat waktu.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN menjadi $\geq 90\%$ dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Penyebab yang diidentifikasi - Tidak adanya jadwal pelaporan yang terstandart - Minimnya kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan tepat waktu - Beban kerja IPCLN yang tinggi tanpa pengganti saat berhalangan - Tidak adanya system pemantauan atau pengingat pelaporan 4. Tindakan - Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo - Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuah IPCLN dan PIC PPI dalam

	melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi. c. Lakukan evaluasi bulanan terhadap kepatuhan pelaporan tiap unit
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans mencapai target 100% dengan upaya, 1. Distribusikan SOP dan jadwal pelaporan kepada seluruh IPCLN 2. Terapkan system pengingat via digital (Wa grub) H-1 dari jadwal pelaporan 3. IPCLN diminta mengisi format laporan harian atau mingguan secara elektronik 4. IPCN mencatat waktu terima laporan dari tiap unit sebagai bahan evaluasi
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan Juni 2025 sebesar 78,54% dengan rerata 70,35% dan belum memenuhi standart 100% 2. Bandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi 3. Evaluasi kendala yang muncul selama implementasi 4. Lakukan kuesioner singkat atau FGD dengan IPCLN untuk mendapatkan umpan balik
ACTION	1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMSbAEduydwSi-AOWHlxYA8QYuDgE/edit?usp=sharing>

- I. Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam Tumpahan B3 dan DUH Tubuh
- Gambar 4.1.3.9 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.9 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan Juni 2025 sebesar 16,67% dengan rerata belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.10 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

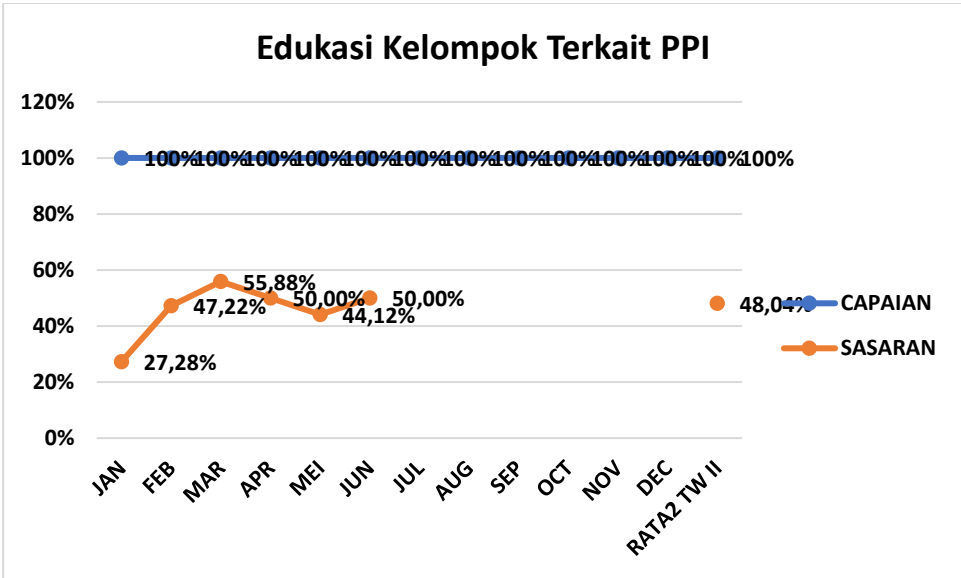
PROBLEM	Petugas tidak menggunakan spill kit secara tepat saat terjadi tumpahan B3 atau darah/urine/cairan tubuh (DUH).
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penggunaan spillkit dalam menangani tumpahan B3 dan DUH tubuh
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan spill kit dalam penanganan tumpahan B3 dan DUH tubuh menjadi ≥ 80% dalam 3 bulan. 2. Penyebab utama a. Spill tidak tersedia dilkoasi yang mudah di akses b. Petugas belum mengetahui prosedur penggunaannya c. Tidak ada pelatihan/praktik secara langsung d. Tidak ada pengawasan atau audit insiden tumpahan 3. Tindakan a. Pastikan keberadaan spill kit diseluruh unit pelayanan beresiko b. Sosialisasi dan pelatihan praktis penggunaan spill kit kepada seluruh petugas c. Tempelkan alur atau poster langkah penggunaan spill kit di area strategis. d. Bentuk tim audit untuk memantau kepatuhan dan tindak lanjut insiden.
DO	1. Distribusikan spill kit ke semua unit yang membutuhkan dan pastikan kelengkapannya 2. Laksanakan pelatihan langsung oleh IPCN/IPCLN (misalnya dengan simulasi tumpahan) 3. Sebarkan media edukasi visual (poster, video singkat). 4. Terapkan form pelaporan jika spill kit digunakan, untuk

	mendokumentasikan insiden.
STUDY	1. Data kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan Juni tahun 2025 sebesar 16,67% dengan rerata 11,90% sehingga belum mencapai standart 100%. 2. Evaluasi jumlah penggunaan spill kit (dari log pelaporan) dibandingkan jumlah insiden. 3. Lakukan survei singkat pemahaman petugas pasca pelatihan. 4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat insiden terjadi.
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. 4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 5. Analisis kebutuhan spill kit di unit

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0Li6EkPMAypTMA/edit?usp=sharing

m. Edukasi Kelompok Terkait PPI

Gambar 4.1.3.10 Edukasi Kelompok terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.10 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI bulan Juni 2025 sebesar 50% dengan rerata belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.4.11 Edukasi Kelompok terkait PPI

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
Januari					
1	IRNA 2A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
6	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
8	RM/PDF	1	8	Hand hygiene	Staff
9	IKO	1	3	Pencegahan Infeksi pada pasien post op	Pencegahan Infeksi
Februari					
1	IRNA 2A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Pemilahan Sampah	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
5	ICU	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
6	IGD	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	6	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
7	IRJA	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
8	Maternitas	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan infeksi	Pasien/pengunjung



9	Neonatologi	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
10	RM/PDF	1	8	Cuci tangan	Staff
Maret					
1	IRNA 2A	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	8	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
8	ICU	2	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
9	Radiologi	1	6	Pemilahan sampah	Pasien/pengunjung
10	IRJA	1	2	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
April					
1	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
5	MATERNITAS	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
6	NEONATOLOGI	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pemilahan sampah	Pasien/Pengunjung
7	ICU	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
8	RM	2	8	Cuci tangan	Staff unit
9	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	8	Etika batuk	Pasien/pengunjung
Mei					

1	IRNA 3A	2	5	Etika Batuk	
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	4	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		2	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
5	IRJA	2	6	Cuci Tangan	Staff
6	Maternitas	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	Perinatologi	1	6	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	6	Pemilahan Sampah	Pasien/Pengunjung
8	ICU	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
9	RM	1	5	Cuci Tangan	Staff
10	IGD	1	7	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	7	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
Juni					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
2	IRNA 3B	3	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Infus Plebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Eefektif	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
7	ICU	3	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
8	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
10	RM	1	8	Cuci Tangan	Staff

Tabel 4.1.4.12 Edukasi Kelompok terkait PPI

PLAN	- Masalah Edukasi kelompok terkait PPI belum dilaksanakan secara rutin atau terdokumentasi dengan baik. - Tujuan Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kelompok PPI $\geq 80\%$ dalam 3 bulan - Analisa masalah - Jadwal edukasi tidak tersusun dengan sistematis. - Petugas tidak patuh dalam melakukan edukasi - Dokumentasi edukasi sering terlewatkan. - Kurangnya koordinasi antar unit dengan IPCN/IPCLN. - Strategi - Susun jadwal edukasi mingguan/bulanan di setiap unit.
-------------	--



	b. Sediakan materi edukasi PPI yang mudah dipahami pasien/keluarga. c. Buat form standar dokumentasi edukasi (manual/digital). d. Tetapkan PIC edukasi di tiap unit pelayanan.
DO	1. Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi. 2. Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif. 3. Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan. 4. IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal.
STUDY	1. Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan terdokumentasi. 2. Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan. 3. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya
ACTION	1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu 2. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu 3. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .

4.2 Kesehatan karyawan
Tabel 4.2. Data Kesehatan Karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	467	206	-	-	-		
4.	April	467	225	-	-	-	Ada penambahan 19 staff yang melakukan MCU Total staff yang belum melaksanakan MCU : 242 staff	
5.	Mei	467	285	-	-	-	Ada penambahan 60 staff yang melakukan MCU Total staff yang belum melaksanakan MCU : 182 staff	
6.	Juni	467	285	-	-	-	-	
		10					10 staff penyaji menjalani uji rectal swab pada tanggal 23/06/2025	Hasil Uji Rectal Swab 1) Rikha : Staphylococcus 2) Rima : Salmonella 3) Veni : Salmonella 4) Bina : Pseudomonas 5) Citra : Eschericia Coli 6) Amel : Salmonella 7) Umi : Salmonela 8) Ratri : Klebsiella 9) Ima : Klebsiella 10) Indy : Escherichia Coli
7.								

Interpretasi : Pada tabel 4.2 terkait data kesehatan karyawan terdapat kegiatan MCU staff pada bulan Juni 2025 sebanyak 10 staff penyaji menjalani uji rectal swab

Tabel 4.2.1 Data Kesehatan Karyawan

PLAN	1. Masalah Hasil pemeriksaan rectal swab pada staf penyaji makanan menunjukkan adanya kontaminasi bakteri patogen, seperti <i>Salmonella</i>, <i>Klebsiella</i>, <i>Staphylococcus</i>, <i>Pseudomonas</i>, dan <i>E. coli</i>. 2. Tujuan Menurunkan risiko transmisi bakteri dari staf penyaji ke makanan pasien/pengunjung serta mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB) akibat kontaminasi makanan. 3. Strategi a. Susun jadwal pengobatan dan pemeriksaan ulang pada 10 staff b. Lakukan edukasi hygiene personal dan food safety pada seluruh penyaji makanan c. Tingkatkan frekuensi cuci tangan dan sanitasi alat di dapur d. Evaluasi kualitas air dan bahan baku makanan sebagai sumber kontaminasi potensial
DO	1. Laksanakan pelatihan terkait, a. Kebersihan tangan b. Pemakaian APD c. Personal hygiene . 2. Supervise harian oleh IPCN/PJ PPI terhadap perilaku hygiene staff dapur 3. Pemeriksaan kualitas air dan lingkungan dapur di lakukan oleh tim sanitasi dan K3RS
STUDY	1. Setelah 2 minggu pengobatan, 3 dari 5 staf telah dinyatakan bebas bakteri pada pemeriksaan ulang. 2. Terjadi peningkatan kepatuhan cuci tangan dan penggunaan APD di dapur dari 60% menjadi 95% (berdasarkan audit PPI). 3. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya
ACTION	1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu terhadap hygiene personal dan food safety 2. Koordinasi dengan PJ PPI untuk melakukan monitoring dan evaluasi staff dapur terhadap hygiene personal dan food safety 3. Tidak ada laporan kejadian diare atau foodborne disease baru dari pasien dalam 1 bulan terakhir 4. Pemeriksaan rectal swab akan dijadwalkan setiap 6 bulan untuk seluruh staf penyaji makanan. 5. Sosialisasi SOP higiene dan keamanan makanan dan semua staf wajib menandatangani komitmen pelaksanaan. 6. Dibentuk Tim Pemantau Sanitasi Dapur dengan audit mingguan.

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja komite PPI pada tahun 2025 didapatkan masih ditemukan banyaknya penilaian yang tidak mencapai target dan masih ditemukan beberapa masalah seperti,

- a. Kepatuhan petugas dalam melakukan *hand hygien*,
- b. Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD,
- c. Kepatuhan penyuntikan,
- d. Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan,
- e. Kepatuhan penanganan limbah,
- f. Kepatuhan penanganan pembuangan jarum dan benda tajam,
- g. Kepatuhan penanganan tumpahan darah,
- h. Kepatuhan pelayanan makanan,
- i. Kejadian phlebitis dalam 2025,
- j. Ketidakpatuhan petugas dalam melakukan pelaporan dan pengisian di web komite PPI 2025

5.2 Saran

Dari hasil penulisan dan pelaporan tahunan Komite PPI 2025 diharapkan adanya perbaikan yang dapat dilakukan oleh semua unit dalam proses pelaporan dan penugasan dari Komite PPI terkait,

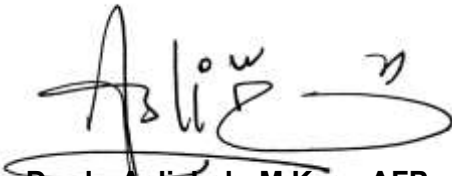
- a. Pengambilan data di unit oleh IPCLN/PIC PPI Unit terkait audit bundle HAI's, pelaporan HAI's, monitoring dan supervisi, sosialis PPI kepada pasien/keluarga/pengunjung pasien,
- b. Evaluasi dalam berjalannya ICRA Program di unit yang berhubungan dengan Bundle HAI's.

BAB VI.
PENUTUP

Demikian laporan bulan Maret tahun 2025 Komite PPI disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Pasuruan, 04 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Komite PPIRS



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

IPCN



Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.

Lampiran :

1. Link Supervisi PPI 2025 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JO8PKQG1PkET_U3IODHmUxZfTRMy1JLkgvpPPzQRRRA/edit?usp=sharing
2. Link Rekap PPI 2025 :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf750mUyrg4oJueUUI58h-qF3exSXqQd/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true>